BLOCK 1-2 NỘI TIM MẠCH

Câu 1 ID: 3096 Bệnh nhân nam 68 tuổi đến phòng khám do đánh trống ngực, đặc biệt rõ rệt trong 2 ngày qua. Tiền sử bệnh lý đáng chú ý có nhồi máu cơ tim và suy tim phân suất tống máu giảm. Các thuốc đang dùng bao gồm aspirin, digoxin, furosemide, sacubitril-valsartan, metoprolol, và atorvastatin. Huyết áp 126/74 mm Hg, mạch 102 lần/phút, nhịp thở 15 lần/phút. Khám thực thể không thấy tiếng thổi hay tiếng tim bệnh lý. Nghe phổi trong. Không có phù ngoại vi. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp nhanh nhĩ kèm block nhĩ thất cấp II. Điều nào sau đây là nguyên nhân có khả năng nhất gây ra bệnh cảnh của bệnh nhân này?

A. Đường dẫn truyền phụ

B. Xơ hóa tế bào cơ tim do tuổi tác

C. Sẹo cơ tim do thiếu máu cục bộ

D. Giãn nhĩ trái

E. Tác dụng phụ của thuốc

Câu 2 ID: 2692 Bệnh nhân nam 56 tuổi đến phòng khám do khó thở tiến triển nặng dần bắt đầu từ 3 tháng trước. Lúc đầu khó thở khi gắng sức, nhưng hiện tại bệnh nhân khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi. Bệnh nhân không có đau ngực, đánh trống ngực, ngất, hoặc phù mắt cá chân. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý đáng chú ý và không dùng thuốc. Tiền sử hút thuốc lá 30 bao-năm và uống nhiều rượu trong 15 năm qua. Không có tiền sử gia đình mắc bệnh tim. Nhiệt độ 37,1 C (98,8 F), huyết áp 113/76 mm Hg, mạch 86 lần/phút. Nghe tim có tiếng T3; không có tiếng thổi. Nghe phổi có ran nổ ở hai đáy phổi. Bụng mềm, không có dấu hiệu cổ trướng. Kết quả xét nghiệm như sau: Tổng phân tích tế bào máu: Hematocrit 32%, Thể tích trung bình hồng cầu (MCV) 101 μm³, Tiểu cầu 120.000/mm³, Bạch cầu 6.000/mm³. Chức năng gan: Phosphatase kiềm 44 U/L, Aspartate aminotransferase (AST/SGOT) 180 U/L, Alanine aminotransferase (ALT/SGPT) 66 U/L. X-quang ngực cho thấy bóng tim to và có dấu hiệu sung huyết tĩnh mạch phổi. Siêu âm tim cho thấy giãn thất trái với phân suất tống máu thất trái ước tính là 25%. Chụp mạch vành không thấy bằng chứng bệnh lý động mạch vành tắc nghẽn. Biện pháp nào sau đây có khả năng nhất giúp đảo ngược tình trạng rối loạn chức năng thất trái của bệnh nhân này?

A. Cai rượu

B. Bỏ hút thuốc lá

C. Bắt đầu điều trị bằng thuốc ức chế men chuyển (ACEi)

D. Bắt đầu điều trị bằng digoxin

E. Bắt đầu điều trị bằng prednisolone

F. Giảm lượng muối tiêu thụ

G. Bổ sung niacin

Câu 3 ID: 3455 Bệnh nhân nam 58 tuổi, chưa đi khám bác sĩ trong 10 năm qua, đến phòng khám để thiết lập hồ sơ theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân than phiền khô ngứa da vùng cẳng chân và tăng cảm giác khó chịu ở chân vào cuối ngày. Bệnh nhân cũng tăng cân đều đặn khoảng 9 kg (20 lb) trong 5 năm qua. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý mạn tính và không dùng thuốc. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá một bao mỗi ngày trong 30 năm nhưng đang cố gắng bỏ vì anh trai mới được chẩn đoán mắc ung thư phổi. Huyết áp 150/84 mm Hg, mạch 80 lần/phút, nhịp thở 16 lần/phút, độ bão hòa oxy máu là 98% ở khí phòng. BMI 34 kg/m². Khám cổ không thấy tĩnh mạch cổ nổi và tuyến giáp bình thường. Khám tim phổi thấy tiếng tim bình thường và tiếng ran rít nhẹ cuối thì thở ra. Hai chi dưới ấm khi sờ ở dưới nếp khoeo hai bên và bắt mạch ngoại vi yếu. Có hăm kẽ (intertrigo) ở nếp bẹn. Tổn thương da được hiển thị trong hình dưới đây. Xét nghiệm/thăm dò nào sau đây có khả năng nhất xác định nguyên nhân gây ra tình trạng da của bệnh nhân này?



A. Chỉ số huyết áp tâm thu cổ chân-cánh tay (ABI)

B. Hemoglobin A1c (HbA1c)

C. Sinh thiết hạch bẹn

D. Nồng độ TSH huyết thanh

E. Test dị ứng da

F. Sinh thiết da

G. Siêu âm Doppler tĩnh mạch

Câu 4 ID: 6853 Bệnh nhân nam 27 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do một cơn ngất. Bệnh nhân ngất xỉu khi đang dỡ các kiện hàng nặng từ xe tải trong một ngày hè nóng bức. Theo nhân chứng, cơn ngất kéo dài 30 giây và bệnh nhân hồi phục ý thức nhanh chóng. Bệnh nhân không có đau ngực hay đánh trống ngực. Trong năm qua, bệnh nhân có những cơn choáng váng ngắn liên quan đến tập thể dục cường độ cao. Tiền sử bệnh lý ngoài ra không có gì đặc biệt. Bệnh nhân làm việc cho một công ty cảnh quan. Huyết áp 130/75 mm Hg khi nằm ngửa và 125/75 mm Hg khi đứng, mạch 78 lần/phút và đều. Độ bão hòa oxy máu là 98% ở khí phòng. Khám thực thể không nghe thấy tiếng thổi ở tim. Nghe phổi trong. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy sóng T âm ở các chuyển đạo V4-V6. Tổng phân tích tế bào máu, điện giải đồ huyết thanh và men tim nằm trong giới hạn bình thường. Bước tiếp theo nào sau đây là phù hợp nhất trong quản lý bệnh nhân này?

A. Theo dõi điện tâm đồ lưu động (Holter ECG)

B. Siêu âm tim

C. Chụp mạch vành

D. Chụp cắt lớp vi tính (CT) động mạch phổi

E. Trấn an và theo dõi định kỳ

Câu 5 ID: 4720 Bệnh nhân nam 64 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do đau ngực dữ dội kèm buồn nôn diễn biến trong 2 giờ. Cơn đau bắt đầu đột ngột và bệnh nhân mô tả như cảm giác xé rách. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp lâu năm và đái tháo đường type 2. Không có tiền sử bệnh động mạch vành hay đột quỵ. Tiền sử hút thuốc lá 35 bao-năm. Bệnh nhân không sử dụng ma túy đường tiêm. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp nhanh xoang không có biến đổi đoạn ST hoặc sóng T đáng kể. Chụp CT mạch máu (CTA) xác nhận lóc tách động mạch chủ lên lan rộng đến quai động mạch chủ. Trong khi bệnh nhân đang được chuẩn bị cho phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân xuất hiện khó thở ngày càng tăng và khó thở khi nằm. Nghe phổi có ran nổ ở hai đáy phổi mà trước đó không có ở lần đánh giá ban đầu. Tiếng T1 mờ và tiếng P2 đanh; có tiếng ngựa phi T3. Nguyên nhân nào sau đây có khả năng nhất gây ra tình trạng mất bù của bệnh nhân này?

A. Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS)

B. Hở van động mạch chủ

C. Lóc tách động mạch chủ xuống

D. Hở van hai lá

E. Ép tim cấp

Câu 6 ID: 17054 Bệnh nhân nữ 26 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do một cơn tiền ngất (suýt ngất). Chồng bệnh nhân cho biết họ đang ăn ở nhà hàng buffet cách đây 20 phút thì cô ấy đột ngột cảm thấy yếu mệt dữ dội và chóng mặt. Bệnh nhân suýt ngã nên anh ấy đã đỡ cô ấy ngồi xuống. Bệnh nhân cũng có buồn nôn, đau quặn bụng, và cảm giác ngứa toàn thân nhưng không đau ngực hay khó thở. Bệnh nhân không có bệnh lý mạn tính nào và không dùng thuốc. Cô ấy đang trong kỳ kinh nguyệt, và chồng cô ấy nói rằng cô ấy thường bị cường kinh (kinh nguyệt ra nhiều). Nhiệt độ 36,7 C (98,1 F), huyết áp 80/50 mm Hg, mạch 120 lần/phút, nhịp thở 20 lần/phút. Khám thực thể thấy bệnh nhân có vẻ mặt mệt mỏi, da đỏ bừng và các chi ấm. Nghe phổi trong, và khám tim bình thường ngoại trừ nhịp nhanh. Bụng mềm với ấn đau nhẹ lan tỏa, âm ruột bình thường. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp nhanh xoang. Ngoài truyền dịch tĩnh mạch, bước tiếp theo nào sau đây là phù hợp nhất trong quản lý bệnh nhân này?

A. Kháng sinh chống tụ cầu

B. Tiêm bắp epinephrine

C. Thuốc ức chế bơm proton (PPI) đường tĩnh mạch

D. Chỉ điều trị hỗ trợ

E. Sốc điện chuyển nhịp đồng bộ

F. Truyền khối hồng cầu nhóm máu O, Rh âm

Câu 7 ID: 2148 Bệnh nhân nữ 82 tuổi đến khoa cấp cứu do đau vùng thượng vị. Bệnh nhân cho biết cơn đau bắt đầu cách đây một giờ và đánh giá điểm đau là 8 trên thang điểm từ 0-10. Bệnh nhân buồn nôn và đã nôn hai lần trong giờ qua. Tiền sử bệnh lý bao gồm đái tháo đường type 2, tăng lipid máu, tăng huyết áp, loét dạ dày tá tràng cách đây 10 năm và sỏi túi mật. Tiền sử hút thuốc lá 40 bao-năm và thỉnh thoảng uống rượu. Nhiệt độ 36,8 C (98,2 F), huyết áp 140/80 mm Hg, mạch 90 lần/phút, nhịp thở 14 lần/phút. Nghe phổi trong. Bụng mềm, không có điểm đau khu trú. Dấu hiệu Murphy âm tính. Thăm dò nào sau đây nên được thực hiện đầu tiên ở bệnh nhân này?

A. Siêu âm ổ bụng

B. Điện tâm đồ (ECG) lúc nghỉ

C. Định lượng lipase huyết thanh

D. Nội soi đường tiêu hóa trên

E. X-quang bụng đứng

Câu 8 ID: 12373 Bệnh nhân nữ 19 tuổi đến khoa cấp cứu do khó chịu ở ngực lan ra nếp gấp gáy và hai vai trong 4-5 ngày qua. Bệnh nhân đã uống ibuprofen không kê đơn và giảm đau phần nào. Bệnh nhân có báo cáo mệt mỏi kèm theo và đau hai khớp gối vào ngày hôm qua, hiện đã thuyên giảm. Tiền sử bệnh lý mắc lupus ban đỏ hệ thống, đang điều trị bằng hydroxychloroquine. Bệnh nhân không hút thuốc lá hay sử dụng ma túy. Không có tiền sử gia đình mắc bệnh lý tim mạch. Nhiệt độ 38,3 C (100,9 F), và huyết áp ở hai chi trên là 110/70 mm Hg. Khám lâm sàng thấy ban đỏ vùng má và sống mũi. Sờ nắn ngực không gây ra đau. Có tiếng thô ráp nông nghe được giữa T1 và T2. Rì rào phế nang bình thường. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp nhanh xoang tần số 103 lần/phút và sóng T âm lan tỏa. Kết quả xét nghiệm như sau: Hemoglobin 10,2 g/dL, Tiểu cầu 90.000/mm³, Creatinine 1,3 mg/dL. Troponin huyết thanh lấy lúc nhập viện là <0,01 ng/dL. Tình trạng nào sau đây là lời giải thích có khả năng nhất cho các triệu chứng của bệnh nhân này?

A. Viêm màng ngoài tim cấp tính

B. Viêm khớp cột sống cổ

C. Viêm sụn sườn

D. Thiếu máu cục bộ cơ tim

E. Thuyên tắc phổi

F. Viêm nội tâm mạc sùi

Câu 9 ID: 4911 Bệnh nhân nữ 62 tuổi đến phòng khám do khó thở. Bệnh nhân có tình trạng khó thở khi gắng sức tiến triển trong 2 tháng qua kèm theo ho thỉnh thoảng. Kết quả nghe tim phổi được cung cấp dưới đây. Tình trạng nào sau đây giải thích tốt nhất các phát hiện ở bệnh nhân này?

A. Phình động mạch chủ lên

B. Viêm màng ngoài tim co thắt

C. Hở van hai lá

D. Hẹp van ba lá

Câu 10 ID: 3826 Bệnh nhân nam 59 tuổi đến khoa cấp cứu do đau ngực bắt đầu cách đây 2 giờ và vã mồ hôi nhiều cách đây 1 giờ. Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi. Tiền sử bệnh lý bao gồm đái tháo đường type 2 và tăng cholesterol máu. Các thuốc bệnh nhân đang dùng bao gồm metformin, glipizide, và simvastatin. Huyết áp đo ở tay phải là 165/98 mm Hg và ở tay trái là 160/90 mm Hg, mạch 78 lần/phút, độ bão hòa oxy máu là 98% ở khí phòng. Bệnh nhân có vẻ khó chịu nhẹ. Nghe phổi trong. Điện tâm đồ (ECG) của bệnh nhân được hiển thị trong phần đính kèm. Bước tiếp theo nào sau đây là tốt nhất trong quản lý bệnh nhân này?



A. Aspirin, định lượng men tim, và theo dõi tại đơn vị chăm sóc tích cực (ICU)

B. Aspirin, truyền heparin, và nhập viện vào khoa có theo dõi monitor

C. Aspirin và chụp can thiệp tim mạch ngay lập tức

D. Chụp cắt lớp vi tính (CT) ngực

E. Thuốc chống viêm không steroid (NSAID) khi cần thiết để giảm đau

Câu 11 ID: 2731 Bệnh nhân nam 60 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do khó thở khi gắng sức và mệt mỏi tiến triển trong 2 tuần. Bệnh nhân khó đi vào giấc ngủ và hầu như không thể đi bộ vào nhà vệ sinh mà không bị khó thở. Bệnh nhân không có đau ngực, ngất, ho hoặc phù chi. Hai tháng trước, bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim thành trước nhưng không được tái thông mạch máu do đến muộn. Bệnh nhân được xuất viện về nhà với các thuốc aspirin, clopidogrel, metoprolol, lisinopril và atorvastatin. Nhiệt độ 36,6 C (97,9 F), huyết áp 100/67 mm Hg, và mạch 67 lần/phút và đều. Khám thấy ran nổ ở hai đáy phổi. Mỏm tim lệch sang trái. Nghe thấy tiếng thổi tâm thu nhỏ ở vùng mỏm tim. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp xoang bình thường và sóng Q sâu ở các chuyển đạo I, aVL và V2-V5, với đoạn ST chênh lên 2 mm; các bản ghi ECG không thay đổi so với lúc xuất viện 2 tháng trước. Điều nào sau đây là nguyên nhân cơ bản có khả năng nhất gây ra các triệu chứng của bệnh nhân này?

A. Viêm màng ngoài tim cấp

B. Đứt cơ nhú

C. Tràn dịch màng ngoài tim

D. Thiếu máu cục bộ tái phát

E. Nhồi máu thất phải

F. Phình vách tâm thất

G. Vỡ thành tự do tâm thất

Câu 12 ID: 17567 Bệnh nhân nam 56 tuổi đang nằm viện được đánh giá do đau ngực tái phát. Bệnh nhân nhập viện 3 ngày trước do đau ngực vùng trước tim diễn biến trong 1 ngày. Đánh giá cho thấy nhồi máu cơ tim cấp và một stent phủ thuốc đã được đặt ở động mạch liên thất trước. Các triệu chứng của bệnh nhân đã thuyên giảm sau thủ thuật nhưng hôm nay bệnh nhân lại thấy đau nhói ở ngực lan ra vai trái. Bệnh nhân chỉ thấy dễ chịu khi ngồi dậy nhưng không có tình trạng khó thở khi nằm hay đánh trống ngực. Các loại thuốc hiện tại bao gồm aspirin, prasugrel, metoprolol và rosuvastatin. Nhiệt độ 37,2 C (99 F), huyết áp 112/70 mm Hg, và mạch 101 lần/phút và đều. Khám thực thể không thấy tiếng thổi ở tim và hai phổi trong. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp nhanh xoang và đoạn PR chênh xuống lan tỏa. Bước tiếp theo tốt nhất trong quản lý bệnh nhân này là điều nào sau đây?

A. Chụp động mạch vành

B. Chụp CT động mạch phổi

C. Siêu âm tim

D. Nghiệm pháp gắng sức

E. Nồng độ troponin huyết thanh

Câu 13 ID: 3933 Bệnh nhân nam 65 tuổi đến phòng khám để tái khám vì tình trạng tăng huyết áp không được kiểm soát đầy đủ. Bệnh nhân không có triệu chứng gì ngoại trừ đau ở đùi phải khi đi bộ lên dốc hoặc leo cầu thang; cơn đau nhanh chóng thuyên giảm khi nghỉ ngơi. Tiền sử bệnh lý bao gồm bệnh động mạch vành với cơn đau thắt ngực ổn định cần nong mạch vành và đặt stent 2 năm trước; bệnh nhân cũng bị tăng cholesterol máu, tiền sử tăng huyết áp 20 năm và tiền sử đái tháo đường type 2 10 năm. Các loại thuốc đang dùng bao gồm aspirin, metoprolol, valsartan, hydrochlorothiazide, amlodipine, atorvastatin và metformin. Bệnh nhân hút 1,5 bao thuốc lá mỗi ngày và không uống rượu. Huyết áp là 177/100 mm Hg ở tay trái và 180/100 mm Hg ở tay phải. Dấu hiệu nào sau đây có khả năng nhất được phát hiện thêm ở bệnh nhân này?

A. Tiếng thổi liên tục ở vùng quanh rốn bên phải

B. Tỷ lệ aldosterone/renin cao >20:1

C. Tăng bài tiết cortisol tự do trong nước tiểu 24 giờ

D. Tăng bài tiết vanillylmandelic acid trong nước tiểu

E. Dấu hiệu ấn lõm xương sườn (rib notching) trên X-quang ngực

Câu 14 ID: 3822 Bệnh nhân nam 51 tuổi đến phòng khám để theo dõi tình trạng tăng đường huyết được phát hiện tình cờ trong quá trình khám sức khỏe để mua bảo hiểm nhân thọ.

Bệnh nhân không có triệu chứng gì ngoài việc đi tiểu nhiều hơn một chút, không có tình trạng bệnh lý nào khác được biết đến và không dùng thuốc gì. Tiền sử bệnh lý gia đình đáng chú ý có đái tháo đường type 2. Bệnh nhân không sử dụng thuốc lá, rượu hoặc các chất kích thích. Nhiệt độ 36,7 C (98,1 F), huyết áp 132/78 mm Hg, mạch 72 lần/phút, và nhịp thở 16 lần/phút. BMI 33 kg/m². Kết quả xét nghiệm lúc đói như sau: Glucose 165 mg/dL, Cholesterol toàn phần 210 mg/dL, LDL 144 mg/dL, Triglyceride 155 mg/dL, HDL 35 mg/dL, Hemoglobin A1c 7,6%, Creatinine huyết thanh 1,1 mg/dL. Ngoài các can thiệp phù hợp để hạ đường huyết, bước tiếp theo nào sau đây là thích hợp nhất để giải quyết những bất thường về lipid của bệnh nhân này?

A. Chỉ thay đổi lối sống tích cực

B. Thay đổi lối sống cộng với evolocumab

C. Thay đổi lối sống cộng với ezetimibe

D. Thay đổi lối sống cộng với phentermine

E. Thay đổi lối sống cộng với rosuvastatin

Câu 15 ID: 4518 Bệnh nhân nam 52 tuổi đến khoa cấp cứu với triệu chứng khó thở và ho khan. Bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi trong vài ngày qua kèm theo khó thở khi gắng sức, mà bệnh nhân cho là do căng thẳng và mệt mỏi trong công việc. Sáng sớm nay, bệnh nhân tỉnh dậy với tình trạng khó thở dai dẳng khiến bệnh nhân phải đến khoa cấp cứu. Bệnh nhân có tiền sử hen phế quản ngắt quãng mức độ nhẹ và thỉnh thoảng sử dụng ống hít albuterol. Tiền sử gia đình không có gì đặc biệt. Nhiệt độ của bệnh nhân là 37,1 C (98,8 F), huyết áp 117/72 mm Hg, mạch 89 lần/phút, và nhịp thở 18 lần/phút. Phân tích xét nghiệm cho thấy nồng độ peptide lợi niệu não (BNP) huyết thanh tăng cao rõ rệt. Dấu hiệu lâm sàng nào sau đây tương quan tốt nhất với phát hiện này ở bệnh nhân?

A. Tím tái

B. Phù ngoại vi

C. Tiếng thổi vùng cổ

D. Tiếng thổi quanh rốn

E. Tiếng tim thứ ba (T3)

F. Tiếng thở rít (Wheezing)

Câu 16 ID: 4484 Bệnh nhân nam 32 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do cơn đau nhức nhối dữ dội ở ngực và cổ khởi phát đột ngột. Bệnh nhân không có tiền sử khó thở, đau ngực hoặc phù chi dưới. Chiều cao 196 cm (6 ft 5 in) với tay chân dài. Các khớp bàn tay có khả năng duỗi quá mức rõ rệt. Có biến dạng ngực ức gà (Pectus carinatum). Phát hiện nào sau đây có khả năng nhất xuất hiện thêm ở bệnh nhân này?

A. Tiếng T3 nghe rõ

B. Tiếng thổi đầu tâm trương

C. T2 tách đôi cố định

D. Tiếng clắc mở van

E. Tiếng cọ màng ngoài tim

F. Mạch nẩy yếu và muộn (Pulsus parvus et tardus)

Câu 17 ID: 21579 Bệnh nhân nữ 52 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu sau một cơn mất ý thức thoáng qua. Bệnh nhân nhớ lại lúc đang vội chạy đi bắt xe buýt đi làm. Cô bắt đầu cảm thấy vã mồ hôi và nóng bừng sau khi ngồi xuống, mất ý thức, và sau đó ngục xuống ghế. Bệnh nhân tỉnh lại sau khoảng một phút và sau đó không bị lú lẫn. Bệnh nhân chưa bao giờ bị tình trạng tương tự và báo cáo không có đau ngực hay đánh trống ngực trước sự việc. Tiền sử bệnh lý bao gồm tăng huyết áp và hội chứng Sjogren. Các loại thuốc đang dùng là amlodipine và nước mắt nhân tạo. Tiền sử gia đình có bố bị nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân không sử dụng thuốc lá và chỉ uống rượu trong các dịp xã giao. Bệnh nhân thường xuyên đi bộ 2 khu nhà mà không thấy khó khăn trên đường đi làm. Khi nằm ngửa, huyết áp là 132/74 mm Hg và mạch 72 lần/phút; khi đứng, huyết áp là 125/70 mm Hg và mạch 78 lần/phút. Khám thực thể không thấy dấu hiệu chấn thương đầu. Khám các dây thần kinh sọ bình thường. Không có yếu cơ hay mất cảm giác khu trú. Nghe phổi trong, và tiếng tim bình thường. Phần còn lại của khám thực thể không thấy bất thường. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp xoang bình thường. Bước tiếp theo thích hợp nhất trong đánh giá bệnh nhân này là điều nào sau đây?

A. Theo dõi Holter 24 giờ

B. Chụp CT sọ não

C. Siêu âm tim

D. Điện não đồ (EEG)

E. Không cần xét nghiệm thêm

F. Nghiệm pháp bàn nghiêng (Tilt-table testing)

Câu 18 ID: 4346 Bệnh nhân nam 52 tuổi đến phòng khám do thường xuyên cảm thấy khó chịu ở ngực trong 6 tuần qua. Cảm giác khó chịu, được mô tả là ở sau xương ức và "âm ỉ", xuất hiện trong nhiều giờ khi bệnh nhân nằm xuống; nó đã làm bệnh nhân thức giấc hầu hết các đêm. Sử dụng nitroglycerin ngậm dưới lưỡi không làm giảm sự khó chịu ở ngực. Hỏi bệnh theo hệ thống cơ quan ghi nhận ho ngắt quãng về đêm. Tiền sử bệnh lý có bệnh động mạch vành đã đặt stent phủ thuốc 3 năm trước. Các loại thuốc hiện tại bao gồm aspirin liều thấp, atorvastatin, metoprolol, và losartan. Huyết áp là 128/78 mm Hg, và nhịp tim là 85 lần/phút. Khám thực thể không có gì bất thường. Điện tâm đồ (ECG) lúc nghỉ không thấy bất thường đáng kể. Bước tiếp theo phù hợp nhất trong quản lý bệnh nhân này là điều nào sau đây?

A. Tăng liều metoprolol để đạt nhịp tim lúc nghỉ <60 lần/phút

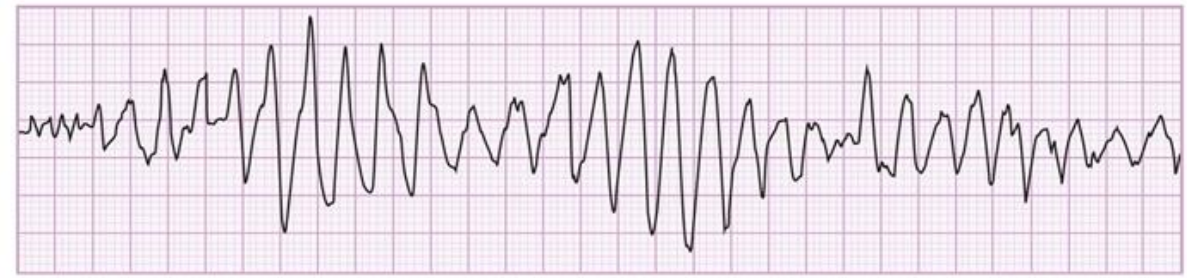
B. Chỉ định xét nghiệm kháng nguyên Helicobacter pylori trong phân

C. Kê đơn liệu pháp ức chế bơm proton (PPI)

D. Chuyển đi chụp can thiệp động mạch vành

E. Chuyển đi đo chức năng hô hấp

Câu 19 ID: 19685 Bệnh nhân nam 57 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu sau khi được tìm thấy trong tình trạng lú lẫn và kích động tại một công viên. Hồ sơ y tế cho thấy bệnh nhân có tiền sử tâm thần phân liệt, rối loạn sử dụng rượu và xơ gan. Bệnh nhân nói rằng mình không uống thuốc "vì chúng chả bao giờ có tác dụng". Nhiệt độ 37,2 C (99 F), huyết áp 160/80 mm Hg, mạch 118 lần/phút, và nhịp thở 24 lần/phút. Khi thăm khám, bệnh nhân lôi thôi và mất phương hướng, cho rằng các đặc vụ FBI đang truy đuổi mình. Hơi thở có mùi rượu. Đồng tử hai bên đều và phản xạ tốt, cổ mềm. Bụng chướng nhưng không đau. Da và niêm mạc khô. Có phù nhẹ ở hai chi dưới nhưng không có biến dạng. Kết quả xét nghiệm như sau: Hóa sinh máu: Natri 128 mEq/L, Kali 4.0 mEq/L, Clorua 88 mEq/L, Bicarbonate 20 mEq/L, BUN (Blood urea nitrogen) 26 mg/dL, Creatinine 2.0 mg/dL, Glucose 60 mg/dL, Amoniac 110 µg/dL, Ethanol 140 mg/dL. Trong quá trình đánh giá, ban đầu bệnh nhân hợp tác nhưng dần trở nên hung hăng và có tính chống đối. Vì lý do an toàn, bệnh nhân được tiêm tĩnh mạch haloperidol và lorazepam. Ngay sau đó, máy theo dõi tim hiển thị nhịp tim như trong phần đính kèm. Yếu tố nào sau đây có khả năng nhất đã góp phần gây ra nhịp tim bất thường của bệnh nhân này?



A. Nồng độ cồn trong máu tăng cao

B. Nồng độ amoniac trong máu tăng cao

C. Tác dụng phụ của haloperidol

D. Tác dụng phụ của lorazepam

E. Mức glucose thấp

F. Mức natri thấp

Câu 20 ID: 2737 Bệnh nhân nam 56 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do cơn đau ngực dữ dội, cảm giác đè ép ở giữa xương ức kèm theo vã mồ hôi và khó thở. Bệnh nhân đã bị đau thắt ngực khi gắng sức trong vài tháng, và, 10 ngày trước, ông đã được chụp động mạch vành cho thấy hẹp 90% đoạn gần động mạch liên thất trước (LAD). Bệnh nhân đã được đặt

stent phủ thuốc, và quá trình sau thủ thuật diễn ra không có biến chứng. Siêu âm tim lúc xuất viện bình thường. Tiền sử bệnh lý cũng đáng chú ý với tăng lipid máu, đái tháo đường type 2, béo phì, và bệnh gút. Bệnh nhân hiện thất nghiệp và không có bảo hiểm. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp nhanh xoang với đoạn ST chênh lên 2 mm ở các chuyển đạo V1-V4. Nguyên nhân nào sau đây có khả năng nhất gây ra tình trạng hiện tại của bệnh nhân này?

A. Viêm màng ngoài tim cấp tính

B. Lóc tách động mạch chủ

C. Vỡ mảng xơ vữa động mạch

D. Hình thành phình vách thất trái

E. Không tuân thủ điều trị bằng thuốc

Câu 21 ID: 4707 Bệnh nhân nam 64 tuổi đến khoa cấp cứu do đánh trống ngực và khó thở tiến triển trong vài tuần qua. Bệnh nhân cho biết ông xuất hiện "cảm giác nghẹt thở kèm theo ho khan" mỗi khi nằm xuống. Bệnh nhân không có đau ngực, khạc đờm, choáng váng hay ngất. Các bệnh lý khác của bệnh nhân bao gồm tăng huyết áp trong 20 năm qua và không tuân thủ điều trị bằng thuốc. Bệnh nhân cũng có tiền sử hút thuốc lá 35 bao-năm. Bố của bệnh nhân qua đời vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 70, và mẹ của ông bị hen phế quản. Huyết áp 182/105 mm Hg và mạch 120 lần/phút, nhịp không đều hoàn toàn. Khám phổi thấy ran nổ hai đáy phổi. Bệnh nhân có phù ấn lõm 2+ ở hai chi dưới. Siêu âm tim tại giường cho thấy tâm thất trái kích thước bình thường kèm phì đại thành tim, phân suất tống máu thất trái 55%, và không có bệnh lý van hai lá hay van động mạch chủ đáng kể. Điều nào sau đây có khả năng nhất gây ra các triệu chứng của bệnh nhân này?

A. Tâm phế mạn

B. Rối loạn chức năng tâm trương

C. Suy tim cung lượng cao

D. Bệnh động mạch vành nhiều nhánh

E. Co thắt phế quản đường thở nhỏ

Câu 22 ID: 2701 Bệnh nhân nữ 37 tuổi đến khoa cấp cứu do yếu nửa người bên trái bắt đầu từ vài giờ trước. Cô không bị sốt, đau đầu, hay thay đổi thị lực. Trong 6 tháng qua, bệnh nhân bị khó thở khi gắng sức tiến triển, ho về đêm và thỉnh thoảng ho ra máu. Cô cũng thường xuyên có các cơn đánh trống ngực và nhịp tim không đều. Bệnh nhân di cư từ Campuchia 2 năm trước. Cô chưa bao giờ hút thuốc lá và không sử dụng rượu. Khám thần kinh thấy có liệt nhẹ nửa người (bán liệt) bên trái. Chẩn đoán nào sau đây là có khả năng nhất?

A. Hở van động mạch chủ

B. Bệnh cơ tim phì đại

C. Hẹp van hai lá

D. Tăng áp động mạch phổi

E. Hội chứng Wolff-Parkinson-White

Câu 23 ID: 20899 Bệnh nhân nữ 42 tuổi đến khám theo dõi sau một đợt nhiễm khuẩn tiết niệu gần đây đã được điều trị bằng một đợt kháng sinh ngắn ngày. Trong lần đến khám tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được thông báo rằng huyết áp của cô "hơi cao". Hiện tại cô không có triệu chứng gì. Tiền sử bệnh lý ngoài ra không có gì đặc biệt, và bệnh nhân không đi khám bác sĩ thường xuyên. Tiền sử gia đình không có gì đặc biệt. Bệnh nhân chạy bộ hai lần một tuần và có chế độ ăn uống lành mạnh. Cô không dùng loại thuốc nào. Huyết áp là 142/91 mm Hg. BMI là 28 kg/m². Khám thực thể không thấy gì bất thường. Điện tâm đồ (ECG) và các xét nghiệm, bao gồm bảng sinh hóa máu cơ bản, không có gì bất thường. Bước tiếp theo tốt nhất trong quản lý bệnh nhân này là điều nào sau đây?

A. Khuyên giảm cân và tái khám sau 12 tháng

B. Lấy nhiều số đo huyết áp tại nhà

C. Đo đa ký giấc ngủ

D. Bắt đầu liệu pháp chống tăng huyết áp phối hợp hai thuốc

E. Bắt đầu sử dụng một thuốc chống tăng huyết áp

Câu 24 ID: 3046 Bệnh nhân nữ 30 tuổi đến khoa cấp cứu với triệu chứng chóng mặt từng cơn và mất thăng bằng trong 2 tuần qua. Kể từ ngày hôm qua, các triệu chứng của cô có vẻ tồi tệ hơn và cô đã có một vài cơn tiền ngất. Bệnh nhân không bị đau ngực nhưng có khó thở nhẹ. Tiền sử bệnh lý đáng chú ý với béo phì, hen phế quản ngắt quãng, và ho mạn tính. Cô từng bị một đợt viêm màng bồ đào 6 tháng trước được điều trị bằng thuốc tại chỗ. Cô không hút thuốc lá và chỉ uống rượu trong những dịp đặc biệt. Bệnh nhân không nuôi thú cưng và chung thủy với một bạn tình trong 3 năm qua. Khám thực thể thấy nhiệt độ 37,2 C (98,9 F), huyết áp 126/76 mm Hg, mạch 36 lần/phút, và nhịp thở 16 lần/phút. Không có tiếng thổi ở tim. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp xoang với block nhĩ thất 2:1 và block nhánh trái. X-quang ngực cho thấy các đám mờ ở giữa hai phế trường. Chẩn đoán nào sau đây là có khả năng nhất?

A. Bệnh động mạch vành

B. Cường giáp

C. Bệnh Lyme

D. Bệnh Sarcoidosis (U hạt)

E. Viêm cơ tim do virus

Câu 25 ID: 20734 Bệnh nhân nữ 28 tuổi đến khoa cấp cứu do đánh trống ngực và cảm giác tim đập nhanh trong 3 giờ qua. Trong năm qua, cô đã có các cơn tương tự có thể tự thuyên

giảm khi hít thở sâu, nhưng cơn lần này kéo dài lâu hơn. Bệnh nhân không có bệnh lý mạn tính nào và không dùng thuốc gì. Cô không sử dụng thuốc lá, rượu, caffeine, hay ma túy. Huyết áp là 100/68 mm Hg, và mạch là 164 lần/phút, đều. Cổ mềm, tuyến giáp bình thường và không có hạch to. Nghe phổi trong. Điện tâm đồ (ECG) được hiển thị trong phần đính kèm. Nguyên nhân nào sau đây có khả năng nhất gây ra các triệu chứng của bệnh nhân này?



A. Tính tự động bất thường của hệ thống dẫn truyền tâm thất

B. Vòng vào lại điện học bất thường xung quanh mô sẹo

C. Hoạt động nhĩ vô tổ chức bắt nguồn từ các tĩnh mạch phổi

D. Hai đường dẫn truyền riêng biệt trong nút nhĩ thất

Câu 26 ID: 4594 Bệnh nhân nam 46 tuổi đến khám bác sĩ do khó thở khi gắng sức và ho khan. Bệnh nhân cũng thỉnh thoảng có những cơn ho ngạt thở về đêm, chỉ đỡ khi ngồi dậy. Tiền sử bệnh lý đáng chú ý có nhồi máu cơ tim 6 tháng trước và tăng cholesterol máu. Các thuốc đang dùng bao gồm metoprolol, aspirin và rosuvastatin. Bệnh nhân uống rượu trong các dịp giao lưu xã hội nhưng không hút thuốc lá hay sử dụng ma túy. Bố của ông qua đời do đột quỵ và mẹ ông mắc đái tháo đường type 2. Huyết áp là 150/100 mm Hg và mạch là 60 lần/phút. Khám ngực thấy ran nổ hai đáy phổi. Mỏm tim sờ thấy ở khoang liên sườn sáu bên trái. Có phù ấn lõm hai chân. Đặc điểm nào sau đây có khả năng liên quan nhất đến tình trạng của bệnh nhân này?

A. Co tiểu động mạch đi của thận

B. Giảm áp lực keo huyết tương

C. Giảm áp lực tĩnh mạch thận

D. Giãn tiểu động mạch đến của thận

E. Lượng natri phân phối đến ống lượn xa cao

F. Tăng phân phối clorua đến phức hợp cận cầu thận (macula densa)

Câu 27 ID: 4646 Bệnh nhân nam 43 tuổi có tiền sử đái tháo đường type 2 trong 2 năm đến phòng khám để khám sức khỏe dự phòng định kỳ. Bệnh nhân cảm thấy khỏe và không có triệu chứng gì. Các thuốc đang dùng bao gồm metformin và aspirin. Bệnh nhân làm lập trình viên máy tính và có lối sống tĩnh tại. Bệnh nhân uống 1 hoặc 2 lon bia vào cuối tuần và có tiền sử hút thuốc lá 20 bao-năm. Bệnh nhân cao 183 cm (6 ft) và nặng 109 kg (240 lb); BMI là 32,5 kg/m². Huyết áp là 153/94 mm Hg và mạch là 82 lần/phút. Phần còn lại của khám thực thể không thấy gì bất thường. Hemoglobin A1c là 7,6%. Ở lần khám trước cách đây 3

tháng, huyết áp là 149/92 mm Hg. Biện pháp can thiệp nào sau đây có khả năng nhất làm giảm huyết áp nhiều nhất cho bệnh nhân này?

A. Giảm 15 kg (33 lb) cân nặng

B. Tập thể dục nhịp điệu (Aerobic)

C. Ngừng uống rượu bia

D. Hạn chế lượng muối trong chế độ ăn

E. Bỏ hút thuốc lá

Câu 28 ID: 4334 Bệnh nhân nữ 36 tuổi đến khoa cấp cứu do đau ngực khởi phát đột ngột khi cô đang mua sắm tại trung tâm thương mại. Bệnh nhân cũng có khó thở, đánh trống ngực và vã mồ hôi. Cơn đau ở sau xương ức và lan xuống cánh tay trái. Không có yếu tố làm tăng hoặc giảm đau. Trông cô có vẻ khó chịu nhẹ. Khi hỏi bệnh theo hệ thống cơ quan, bệnh nhân báo cáo bị sổ mũi, đau họng và ho khan trong 3 ngày qua. Các vấn đề y tế khác của cô bao gồm các cơn hoảng sợ được điều trị bằng paroxetine và chảy máu tử cung cơ năng được điều trị bằng estrogen. Tiền sử gia đình đáng chú ý có bố cô đột ngột qua đời ở tuổi 44 do nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá 15 bao-năm. Huyết áp của cô là 144/90 mm Hg và mạch là 104 lần/phút, đều. Chỉ số khối cơ thể (BMI) của cô là 29 kg/m². Điều trị khởi đầu phù hợp nhất cho bệnh nhân này là gì?

A. Acetaminophen

B. Aspirin

C. Heparin

D. Ibuprofen

E. Lorazepam

F. Oxycodone

Câu 29 ID: 12118 Một thai phụ 34 tuổi, mang thai lần đầu chưa sinh (PARA 1000), đến phòng khám ở tuần thứ 38 của thai kỳ do khó thở ngày càng tăng. Bệnh nhân nói rằng việc mang thai gây ra quá nhiều khó chịu và yêu cầu được cho sinh. Cô không thể tìm được tư thế ngủ thoải mái, và sau khi đi được vài bước, cô phải dừng lại để lấy hơi. Thai kỳ của bệnh nhân diễn ra bình thường không có biến chứng, và cô không có tình trạng bệnh lý đáng chú ý nào. Cô không sử dụng thuốc lá hay rượu. Huyết áp là 132/85 mm Hg và mạch là 112 lần/phút, đều. Nghe tim có tiếng T3. Nghe thấy một tiếng thổi toàn tâm thu mới xuất hiện độ III/VI ở mỏm tim. Có phù ấn lõm ở hai chi dưới lan lên tới ngay dưới đầu gối. Tổng phân tích nước tiểu cho thấy vết protein. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp nhanh xoang. Bước tiếp theo tốt nhất trong quản lý bệnh nhân này là điều nào sau đây?

A. X-quang ngực

B. Siêu âm tim

C. Cho sinh ngay lập tức

D. Magie sulfat (Magnesium sulfate)

E. Trấn an và chăm sóc thường quy

Câu 30 ID: 4243 Bệnh nhân nam 84 tuổi đến khoa cấp cứu với tiền sử khó thở trong 4 tháng nay, gần đây tình trạng ngày càng nặng hơn. Bệnh nhân không thể nằm đầu bằng và phải ngủ trên ghế. Tiền sử bệnh lý bao gồm tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Bệnh nhân từng nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp một năm trước nhưng không đi tái khám bác sĩ. Huyết áp là 144/82 mm Hg và mạch là 98 lần/phút, đều. Khám thực thể thấy phù ấn lõm hai chi dưới. Mỏm tim (điểm đập tối đa) bị lệch sang trái, và nghe thấy tiếng thổi toàn tâm thu ở mỏm tim. Khám phổi thấy ran nổ hai đáy phổi. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp xoang với thay đổi đoạn ST và sóng T không đặc hiệu. Siêu âm tim và thông tim được thực hiện để xác định chỉ số tim, sức cản mạch máu hệ thống, và thể tích cuối tâm trương thất trái. Mẫu thay đổi huyết động nào sau đây có khả năng nhất được nhìn thấy ở bệnh nhân này?

A. Chỉ số tim ↓, Sức cản mạch máu hệ thống ↓, Thể tích cuối tâm trương thất trái ↓

B. Chỉ số tim ↓, Sức cản mạch máu hệ thống ↑, Thể tích cuối tâm trương thất trái ↓

C. Chỉ số tim ↓, Sức cản mạch máu hệ thống ↑, Thể tích cuối tâm trương thất trái ↑

D. Chỉ số tim ↓, Sức cản mạch máu hệ thống ↑, Thể tích cuối tâm trương thất trái Bình thường

E. Chỉ số tim Bình thường, Sức cản mạch máu hệ thống ↓, Thể tích cuối tâm trương thất trái ↑

Câu 31 ID: 4235 Bệnh nhân nam 60 tuổi được sinh thiết phổi phải để chẩn đoán bệnh phổi hạn chế. Hai giờ sau thủ thuật, bệnh nhân xuất hiện khó thở dữ dội và đau ngực. Các vấn đề y tế khác của bệnh nhân bao gồm tăng huyết áp, tăng lipid máu, thiếu máu ác tính và sửa thoát vị bẹn cách đây 10 năm. Bệnh nhân không hút thuốc lá và thỉnh thoảng mới uống rượu. Huyết áp là 70/40 mm Hg, mạch là 118 lần/phút, nhịp thở là 30 lần/phút. Bệnh nhân vã mồ hôi, da lạnh và ẩm. Đồng tử hai bên đều và phản xạ ánh sáng tốt. Bệnh nhân được thiết lập theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn và đặt catheter động mạch phổi. Các chỉ số đo được ban đầu như sau: Chỉ số tim 2,3 L/min/m² (bình thường, 2,8-4,2), Áp lực mao mạch phổi bít 26 mm Hg (bình thường, 6-12). Chẩn đoán nào sau đây là có khả năng nhất ở bệnh nhân này?

A. Sốc phản vệ

B. Nhồi máu cơ tim

C. Phù phổi không do tim

D. Thuyên tắc động mạch phổi

E. Xuất huyết nhu mô phổi

F. Sốc nhiễm khuẩn

G. Tràn khí màng phổi áp lực

H. Giảm thể tích tuần hoàn

Câu 32 ID: 4453 Bệnh nhân nam 56 tuổi đến phòng khám do mệt mỏi ngày càng trầm trọng, khó tập trung và ngày càng hay quên trong vài tuần qua. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị đau bụng âm ỉ, táo bón và tăng 2,7 kg (6 lb) ngoài ý muốn trong 3 tháng qua. Tiền sử bệnh lý đáng chú ý với tăng huyết áp, bệnh cơ tim không do thiếu máu cục bộ kèm rối loạn chức năng tâm thu thất trái và rung nhĩ. Huyết áp là 140/90 mm Hg và mạch là 75 lần/phút. Khám thực thể thấy tiếng tim đều với T1 và T2 bình thường. Nghe phổi trong. Không có phù chi dưới, da trông khô. Kết quả xét nghiệm như sau: Natri 136 mEq/L, Kali 4,4 mEq/L, Clorua 98 mEq/L, BUN (Blood urea nitrogen) 28 mg/dL, Creatinine 1,2 mg/dL, Glucose 100 mg/dL, Phosphatase kiềm 120 U/L, Aspartate aminotransferase (AST/SGOT) 62 U/L, Alanine aminotransferase (ALT/SGPT) 74 U/L. Loại thuốc nào sau đây có khả năng nhất gây ra các triệu chứng hiện tại của bệnh nhân này?

A. Amiodarone

B. Digoxin

C. Dofetilide

D. Hydralazine

E. Metoprolol

F. Verapamil

Câu 33 ID: 20294 Bệnh nhân nữ 32 tuổi được đưa đến phòng cấp cứu do mất thăng bằng và chóng mặt diễn biến trong 12 giờ. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh lý thần kinh, chấn thương gần đây hay phẫu thuật. Nhiệt độ là 36,7 C (98,1 F), huyết áp là 118/78 mm Hg, mạch là 80 lần/phút và nhịp thở là 15 lần/phút. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp xoang bình thường. Kết quả xét nghiệm như sau: Hematocrit 31%, Bạch cầu 4.200/mm³, Tiểu cầu 88.000/mm³. Hình ảnh học thần kinh cho thấy nhồi máu tiểu não cấp tính. Siêu âm tim cho thấy một vài đám mờ nhỏ dao động trên van hai lá kèm theo hở nhẹ. Cấy máu nhiều lần và kiểm tra thêm trên diện rộng về căn nguyên nhiễm trùng đều âm tính. Bước tiếp theo phù hợp nhất trong quản lý bệnh nhân này là gì?

A. Theo dõi điện tâm đồ lưu động (Holter ECG)

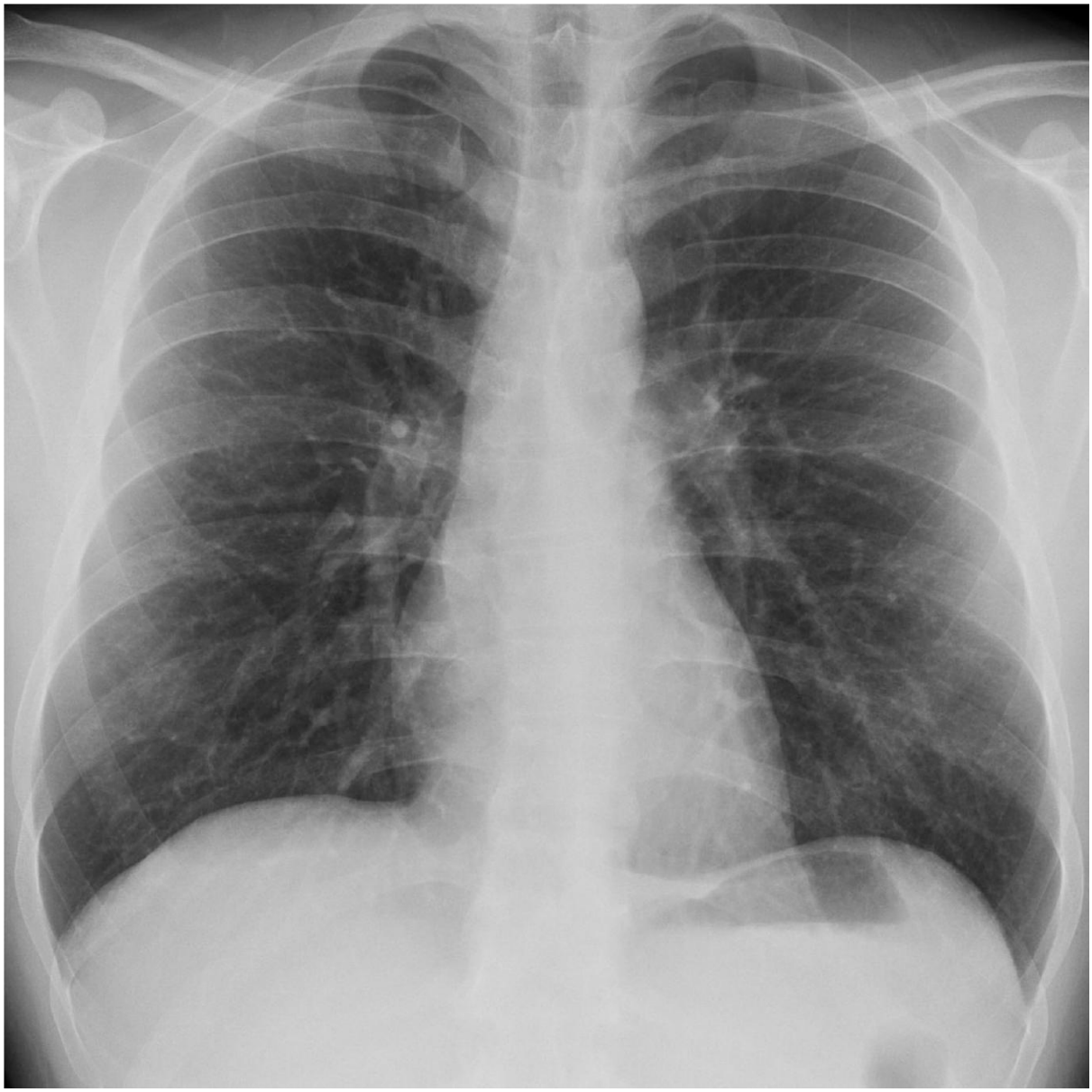
B. Xét nghiệm kháng thể kháng bào tương của bạch cầu đa nhân trung tính (ANCA)

C. Xét nghiệm kháng thể kháng phospholipid

D. Sàng lọc ung thư đại tràng

E. Phẫu thuật van hai lá

Câu 34 ID: 4396 Bệnh nhân nam 46 tuổi đến khoa cấp cứu do đau ngực và khó thở trong 10 giờ qua. Đau nhói và không lan. Bệnh nhân nói rằng việc thở nông giúp tránh bị đau. Bệnh nhân tự coi mình khỏe mạnh và chưa bao giờ có các triệu chứng như thế này trước đây. Bệnh nhân dùng thuốc kháng axit không kê đơn cho chứng ợ nóng thường xuyên. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá 25 bao-năm, nhưng không sử dụng rượu hay các chất kích thích. Bố bệnh nhân qua đời vì nhồi máu cơ tim ở tuổi 47. Bệnh nhân làm nghề lái xe tải đường dài. Nhiệt độ là 36,7 C (98 F), huyết áp là 110/70 mm Hg, mạch là 110 lần/phút và nhịp thở là 31 lần/phút. Chỉ số khối cơ thể (BMI) là 29 kg/m². Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp nhanh xoang. X-quang ngực được hiển thị trong hình đính kèm. Chẩn đoán nào sau đây là có khả năng nhất ở bệnh nhân này?



A. Nhồi máu cơ tim cấp

B. Lóc tách động mạch chủ lên

C. Thủng ổ loét dạ dày tá tràng

D. Tràn khí màng phổi

E. Thuyên tắc phổi

Câu 35 ID: 15761 Bệnh nhân nữ 34 tuổi có tiền sử bệnh cơ tim giãn vô căn đến khoa cấp cứu do tăng cân tiến triển và khó thở khi gắng sức. Bệnh nhân đã không uống thuốc trong kỳ nghỉ lễ gần đây. Huyết áp là 110/70 mm Hg, mạch là 90 lần/phút, đều. Độ bão hòa oxy ở mức 92% trong khí phòng. Khám thực thể thấy tĩnh mạch cổ nổi kèm phù ấn lõm rõ rệt ở bàn chân. Có ran nổ ở hai đáy phổi. Nghe tim thấy tiếng thổi toàn tâm thu độ 3/6 nghe rõ nhất ở mỏm tim. Bệnh nhân được nhập viện và bắt đầu điều trị thích hợp bằng thuốc lợi tiểu đường tĩnh mạch. Bốn ngày sau, các triệu chứng của bệnh nhân đã cải thiện và cô ấy đã sẵn sàng xuất viện. Cân nặng đã giảm 5 kg (11 lb) kể từ khi nhập viện. Khi thăm khám, nghe phổi trong và không nghe thấy tiếng thổi ở tim. Lời giải thích nào sau đây phù hợp nhất cho tiếng thổi ở tim nghe được ở bệnh nhân này lúc nhập viện?

A. Tắc nghẽn đường ra thất trái động lực

B. Tăng lưu lượng qua đường ra thất phải

C. Tăng lưu lượng qua lỗ bầu dục còn thông

D. Sự di lệch của cơ nhú thất trái

E. Sa lá sau van hai lá

Câu 36 ID: 2738 Bệnh nhân nam 56 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do đau ngực. Một giờ trước, bệnh nhân thức dậy với cơn đau ngực dữ dội, nóng rát sau xương ức kèm theo đổ mồ hôi và tê cánh tay trái. Các triệu chứng của bệnh nhân đã thuyên giảm nhờ aspirin và nitroglycerin ngậm dưới lưỡi do nhân viên cấp cứu cho; hiện tại bệnh nhân đánh giá mức độ đau là 4 trên thang điểm từ 0-10. Bệnh nhân không buồn nôn, không nôn, không khó chịu vùng bụng. Bệnh nhân có tiền sử bệnh trào ngược dạ dày thực quản và đái tháo đường kiểm soát bằng chế độ ăn uống. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá 30 bao-năm. Nhiệt độ là 37,3 C (99 F), huyết áp là 150/90 mm Hg ở tay phải và 145/88 mm Hg ở tay trái, mạch là 95 lần/phút, đều. Nghe phổi trong, tiếng tim bình thường, không có tiếng thổi hay tiếng ngựa phi. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp xoang bình thường với sóng T âm ở các chuyển đạo từ V1 đến V4. Mức troponin bình thường. Bước tiếp theo phù hợp nhất trong quản lý bệnh nhân này là điều nào sau đây?

A. Nghiệm pháp gắng sức thể lực

B. Alteplase đường tĩnh mạch

C. Truyền tĩnh mạch heparin

D. Tiêm lidocaine

E. Thuốc ức chế bơm proton (PPI) đường uống

Câu 37 ID: 2224 Bệnh nhân nam 71 tuổi được đưa đến phòng cấp cứu do đau nhói ở ngực trong 2 giờ. Cơn đau không liên quan đến gắng sức nhưng dữ dội hơn khi hít thở sâu. Bệnh

nhân không thực hiện hoạt động bất thường nào gần đây. Bệnh nhân có tiền sử bệnh thận mạn tính giai đoạn muộn và đang chuẩn bị bắt đầu chạy thận nhân tạo mạn tính sớm. Các vấn đề y tế khác bao gồm đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, và hẹp ống sống thắt lưng. Bệnh nhân không sử dụng thuốc lá hay ma túy nhưng uống 1 ly rượu vào bữa tối hầu hết các tối. Nhiệt độ là 37,7 C (99,8 F), huyết áp là 160/98 mm Hg ở cả hai tay, mạch là 98 lần/phút, nhịp thở là 20 lần/phút. Khi được đặt ở tư thế nằm ngửa trong quá trình thăm khám, bệnh nhân bị đau ngực và có vẻ cải thiện khi bệnh nhân ngồi dậy. Nghe thấy âm sắc tâm trương có tính chất rít ở bờ trái xương ức. Rì rào phế nang bình thường. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy sóng T bất thường không đặc hiệu. X-quang ngực bình thường. Men tim bình thường. Kết quả xét nghiệm cho thấy mức BUN là 68 mg/dL và creatinine huyết thanh là 5,3 mg/dL. Chẩn đoán nào sau đây là có khả năng nhất?

A. Lóc tách động mạch chủ

B. Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

C. Nhồi máu cơ tim

D. Viêm màng ngoài tim

E. Thuyên tắc phổi

F. Đau thắt ngực không ổn định

G. Viêm màng phổi do virus

Câu 38 ID: 4673 Bệnh nhân nữ 24 tuổi đến phòng khám do khó thở khi gắng sức và mệt mỏi trong 2 tháng. Bệnh nhân cảm thấy choáng váng và gần như ngất xỉu khi chạy trên máy chạy bộ gần đây. Bệnh nhân bị nhiễm trùng đường hô hấp trên cách đây 3 tháng đã khỏi sau 3-4 ngày. Bệnh nhân không dùng thuốc nào. Nhiệt độ 37,2 C (99 F), huyết áp 126/76 mm Hg, mạch 76 lần/phút, nhịp thở 14 lần/phút. Độ bão hòa oxy là 98% trong khí phòng. Khám thực thể thấy bệnh nhân không có biểu hiện khó thở rõ rệt. Áp lực tĩnh mạch cảnh bình thường. Nghe phổi trong. Nghe thấy tiếng thổi tâm thu âm sắc tăng-giảm dọc bờ trái xương ức không lan lên cổ. Bắt mạch ngoại vi nảy mạnh. X-quang ngực bình thường. Nguyên nhân nào sau đây có khả năng nhất gây ra các triệu chứng của bệnh nhân này?

A. Van động mạch chủ hai lá van

B. Giảm co bóp cơ tim

C. Phì đại vách liên thất

D. Luồng thông phải-trái trong tim

E. Tắc nghẽn đường ra thất phải (Pulmonary outflow tract obstruction)

Câu 39 ID: 20478 Bệnh nhân nam 58 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do đau ngực dữ dội khởi phát cách đây một giờ. Bệnh nhân mô tả cơn đau có cảm giác như đè ép ở giữa ngực. Bệnh nhân cũng buồn nôn nhưng không khó thở. Tiền sử bệnh lý đáng chú ý có tăng huyết áp và đái tháo đường kiểm soát bằng chế độ ăn. Nhiệt độ là 37,6 C (99,7 F), huyết áp là

94/62 mm Hg, mạch là 64 lần/phút. Khi khám thực thể, bệnh nhân vã mồ hôi. Nghe tim thấy tiếng T1 và T2 bình thường, không có tiếng thổi hay tiếng tim bất thường. Nghe phổi trong. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy đoạn ST chênh lên ở các chuyển đạo II, III, aVF, và V4R. Những phát hiện huyết động nào sau đây có khả năng nhất hiện diện ở bệnh nhân này?

A. Tiền gánh thất phải ↓, Tiền gánh thất trái ↓, Sức cản mạch máu hệ thống ↓

B. Tiền gánh thất phải ↓, Tiền gánh thất trái ↑, Sức cản mạch máu hệ thống ↓

C. Tiền gánh thất phải ↑, Tiền gánh thất trái ↓, Sức cản mạch máu hệ thống ↑

D. Tiền gánh thất phải ↑, Tiền gánh thất trái ↑, Sức cản mạch máu hệ thống ↓

E. Tiền gánh thất phải ↑, Tiền gánh thất trái ↑, Sức cản mạch máu hệ thống ↑

Câu 40 ID: 17858 Bệnh nhân nam 45 tuổi đến phòng khám do nhiều lần đo huyết áp bất thường trong năm qua. Bệnh nhân cũng cảm thấy mệt mỏi mà anh ấy cho là do căng thẳng trong công việc. Bệnh nhân là thợ mộc và chế độ ăn của anh ấy chủ yếu bao gồm thức ăn nhanh vài lần mỗi ngày vì bận rộn với công việc tại công trường. Bệnh nhân thức dậy vài lần vào ban đêm và thỉnh thoảng cảm thấy khó ngủ lại. Bệnh nhân không có đau ngực, khó thở, choáng váng hay ngất. Tiền sử gia đình không có ai mắc bệnh tăng huyết áp, đột quỵ và bệnh động mạch vành khởi phát sớm. Bệnh nhân uống 2 cốc bia mỗi ngày vào cuối tuần. Huyết áp là 151/90 mm Hg ở tay phải và 159/95 mm Hg ở tay trái. Huyết áp đo lại ở tay trái là 158/94 mm Hg. Mạch 78 lần/phút, đều. Chỉ số khối cơ thể (BMI) là 32 kg/m². Khám thực thể không thấy gì bất thường. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp xoang bình thường không có bất thường. Bảng sinh hóa máu và nồng độ TSH trong giới hạn bình thường. Điều nào sau đây là nguyên nhân cơ bản có khả năng nhất gây ra tình trạng tăng huyết áp của bệnh nhân này?

A. Sử dụng rượu

B. Rối loạn lo âu lan tỏa

C. Ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn (OSA)

D. Cường aldosterone nguyên phát

E. Bệnh lý mạch máu thận

BLOCK 2

Câu 1 ID 15975 Một người phụ nữ 48 tuổi đến phòng khám để khám dự phòng định kỳ. Bệnh nhân cảm thấy khỏe và không đau đầu hay có các triệu chứng tim phổi. Tiền sử bệnh tật không có gì đặc biệt, bệnh nhân không sử dụng thuốc lá hay rượu. Huyết áp là 176/98 mmHg và nhịp mạch là 75 l/p và đều. BMI là 29 kg/m². Khám lâm sàng cho thấy thể trạng thừa cân nhưng ngoài ra bình thường. Kết quả xét nghiệm như sau: Hemoglobin 13.2 g/dL Kali 4.1 mEq/L Canxi 9.5 mg/dL Creatinin 0.8 mg/dL Glucose 85 mg/dL LDL 98 mg/dL TSH 2.2 U/L Tổng phân tích nước tiểu: bình thường Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp xoang bình thường không có dấu hiệu bất thường. Bệnh nhân quay lại sau một tuần, lúc này huyết áp là 178/100 mmHg. Theo dõi tại nhà cho thấy huyết áp trung bình là 174/102 mmHg. Ngoài việc tư vấn thay đổi lối sống, bước xử trí ban đầu nào sau đây là tốt nhất cho bệnh nhân này?

A. Đánh giá thêm về nội tiết sau đó điều trị bằng thuốc hạ huyết áp

B. Chỉ sử dụng các biện pháp không dùng thuốc

C. Đánh giá động mạch thận sau đó điều trị bằng thuốc hạ huyết áp

D. Điều trị bằng hai loại thuốc hạ huyết áp

Câu 2 ID 2687 Một người phụ nữ 27 tuổi đến phòng khám do các đợt đánh trống ngực từng cơn và khó thở khi gắng sức. Huyết áp là 130/80 mmHg và nhịp mạch là 78 l/p. Khám lâm sàng, không có phù ngoại vi hoặc tĩnh mạch cổ nổi. Nghe phổi trong. Nghe thấy tiếng thổi tâm thu dạng tống máu 3/6 dọc theo bờ trái xương ức và giảm cường độ khi bệnh nhân chuyển từ tư thế đứng sang tư thế ngồi xổm. Thông tin bệnh sử bổ sung nào sau đây là hữu ích nhất để thiết lập chẩn đoán?

A. Tiền sử gia đình

B. Sử dụng chất kích thích qua đường tĩnh mạch

C. Sử dụng thuốc

D. Nghề nghiệp

E. Du lịch

Câu 3 ID 8879 Một người phụ nữ 38 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do một cơn ngất. Bệnh nhân cảm thấy yếu và ăn uống kém trong 2 tuần qua. Do đó, cô ấy tin rằng mình bị "mất nước". Nhiệt độ là 38.2 C, huyết áp 112/58 mmHg, nhịp mạch 49 l/p và đều. Niêm mạc miệng khô và tình trạng răng miệng kém. Nghe thấy tiếng thổi tâm trương thì đầu ở bờ trái xương ức khi thở ra hết sức. Nghe phổi trong. Bụng mềm và không đau. ECG cho thấy nhịp xoang với block nhĩ thất độ II kiểu 2:1. Kết quả xét nghiệm như sau: Bạch cầu: 13,000/mm³ Hemoglobin: 10.8 g/dL Tiểu cầu: 410,000/mm³ Chẩn đoán nào sau đây là có khả năng nhất ở bệnh nhân này?

A. Viêm màng ngoài tim cấp

B. Bệnh Lyme

C. Thủng van hai lá

D. Áp xe quanh van

E. Viêm nội tâm mạc van ba lá

Câu 4 ID 2141 Một người đàn ông 78 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu sau một cơn ngất thoáng qua. Từ hôm qua, ông đã bị mệt mỏi và xây xẩm mặt mày. Bệnh nhân không có đau ngực hay đánh trống ngực. Ông có tiền sử tăng huyết áp, bệnh động mạch vành ổn định, đái tháo đường type 2 và tăng mỡ máu. Huyết áp là 82/44 mmHg. Bệnh nhân trông lờ đờ và lú lẫn nhẹ. Nghe phổi trong. Các chi lạnh và thời gian đổ đầy mao mạch là 3 giây. Điện tâm đồ (ECG) được hiển thị trong tài liệu đính kèm. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là phù hợp nhất cho bệnh nhân này?



©UWorld

A. Adenosine

B. Amiodarone

C. Atropine

D. Glucagon

E. Norepinephrine

Câu 5 ID 3526 Một người đàn ông 64 tuổi có tiền sử tăng huyết áp không kiểm soát nhiều năm được đưa đến khoa cấp cứu do đau ngực trong 8 giờ qua. ECG cho thấy nhịp xoang bình thường với ST chênh lên ở các chuyển đạo thành trước. Can thiệp động mạch vành qua da, thực hiện qua đường động mạch đùi phải, cho thấy tắc hoàn toàn đoạn gần động mạch liên thất trước. Tiến hành đặt stent, và bắt đầu điều trị nội khoa phù hợp. Sáu ngày sau, bệnh nhân đột ngột xuất hiện đau dữ dội chân trái. Khám lâm sàng, cẳng chân trái lạnh và có biểu hiện lốm đốm, không sưng phù. Mạch đùi bắt rõ và đều hai bên; mạch mu chân có ở bên phải và không bắt được ở bên trái. Đã hội chẩn ngoại khoa mạch máu. Xét nghiệm/Thăm dò nào sau đây cũng nên được cân nhắc ở bệnh nhân này?

A. Xét nghiệm D-dimer

B. Siêu âm tim

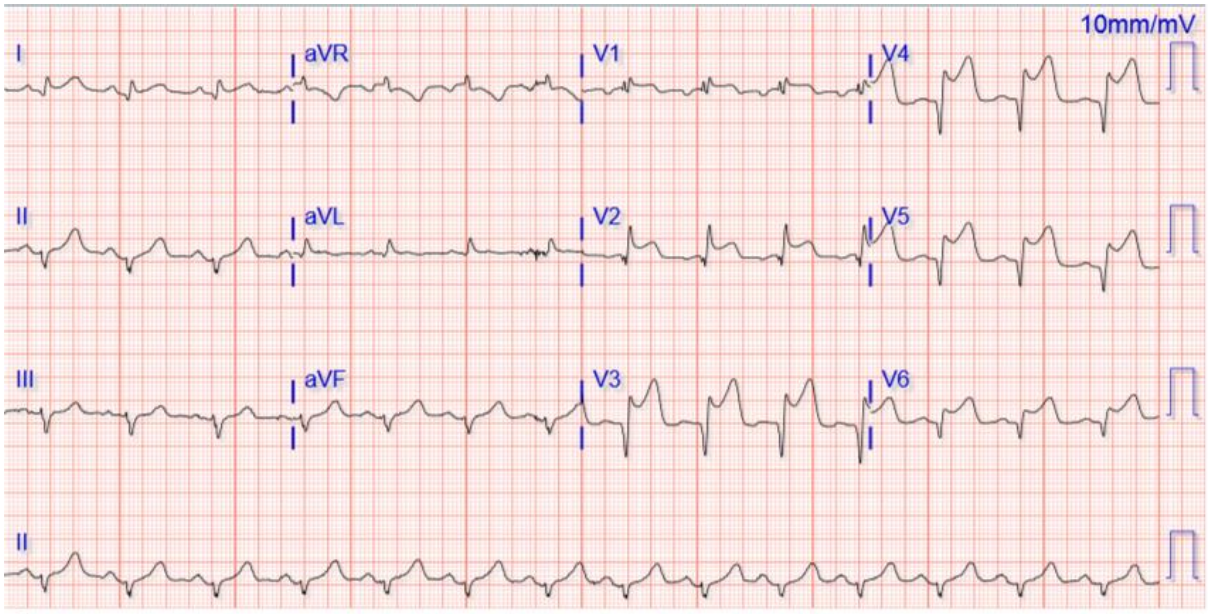
C. Siêu âm Doppler tĩnh mạch chi dưới

D. Siêu âm vùng bẹn phải

E. Xạ hình thông khí - tưới máu (V/Q scan)

Câu 6 ID 19934 Một người phụ nữ 81 tuổi đến khoa cấp cứu do khó thở trầm trọng hơn trong giờ qua. Triệu chứng này đi kèm với buồn nôn. Bệnh nhân không bị đau ngực. Tiền sử

bệnh tật đáng chú ý có tăng huyết áp, tăng mỡ máu và đái tháo đường type 2. Nhiệt độ là 36.7 C, huyết áp 92/64 mmHg, nhịp mạch 70 l/p, và nhịp thở là 22 l/p. Độ bão hòa oxy là 94% với khí trời. Khám lâm sàng, bệnh nhân vã mồ hôi và có biểu hiện suy hô hấp nhẹ. Nghe phổi có ran nổ hai bên. Không nghe thấy tiếng thổi ở tim. Đã ghi điện tâm đồ (ECG) và được hiển thị trong tài liệu đính kèm. Đã gửi các mẫu máu để xét nghiệm. Sau liệu pháp điều trị nội khoa ban đầu tại khoa cấp cứu, bước xử trí tiếp theo nào sau đây là tốt nhất cho bệnh nhân này?



©UWorld

A. Nhập khoa điều trị tích cực để truyền tĩnh mạch dopamine

B. Nhập khoa theo dõi từ xa (telemetry) để lợi tiểu tích cực

C. Chụp cắt lớp vi tính động mạch phổi (CTPA)

D. Chụp mạch vành cấp cứu

E. Phẫu thuật lồng ngực cấp cứu

Câu 7 ID 3767 Một người phụ nữ 80 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do một cơn thấu ngất (near-syncope). Bệnh nhân cảm thấy vô cùng mệt mỏi và khó thở khi gắng sức vừa phải và thỉnh thoảng có đánh trống ngực trong 6 tháng qua. Bà đã có một vài cơn xây xẩm mặt mày thoáng qua trong 2 tuần qua, và hôm nay khi đang đi bộ trong trung tâm mua sắm, bà cảm thấy vô cùng yếu và chóng mặt. Bệnh nhân được gia đình đỡ và không bị ngã hay mất ý thức. Bà không bị đau ngực, ho hay phù chân. Bệnh nhân bị tăng huyết áp, tăng mỡ máu và bệnh động mạch vành đã điều trị bằng phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành 15 năm trước. Bà đang dùng aspirin, atorvastatin và metoprolol. Huyết áp là 136/80 mmHg và nhịp mạch là 52 l/p không có thay đổi tư thế đáng kể. Không có tĩnh mạch cổ nổi. Nghe tim thấy T1 và T2 đều, có thêm tiếng T4. Âm phế bào bình thường, không có ran. Không có phù chi. ECG cho thấy nhịp xoang chậm. Trong thời gian nằm viện, theo dõi tim mạch từ xa (telemonitoring) phát hiện các đợt ngừng xoang kéo dài 3-6 giây không có hoạt động của nút xoang, trong

thời gian đó bệnh nhân thấy chóng mặt. Nguyên nhân nào sau đây có khả năng nhất gây ra tình trạng rối loạn nhịp tim của bệnh nhân này?

A. Đường dẫn truyền tim bất thường

B. Ổ dẫn truyền tâm nhĩ bất thường

C. Thoái hóa hệ thống dẫn truyền tim

D. Những thay đổi phản xạ bình thường của trương lực phó giao cảm

E. Tắc cấp tính động mạch vành phải

Câu 8 ID 20964 Một người đàn ông 62 tuổi đến phòng khám để tái khám bệnh gout. Bệnh gout của ông đã được kiểm soát tốt, không còn đau khớp kể từ khi bắt đầu uống allopurinol 6 tháng trước. Bệnh nhân không bị đau ngực, khó thở, đau đầu hay xây xẩm mặt mày. Ông không sử dụng thuốc lá, rượu hay các chất kích thích. Huyết áp là 155/90 mmHg và 152/95 mmHg trong 2 lần khám trước. Hôm nay, huyết áp là 153/92 mmHg ở tay trái và 156/90 mmHg ở tay phải. Khám lâm sàng bình thường. Kết quả tổng phân tích tế bào máu, creatinin huyết thanh, điện giải đồ huyết thanh, TSH, axit uric và tổng phân tích nước tiểu đều bình thường. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy phì đại thất trái. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là tốt nhất cho bệnh nhân này?

A. Ngừng allopurinol và kiểm tra lại huyết áp trong 4 tuần

B. Chỉ định nghiệm pháp gắng sức

C. Trấn an bệnh nhân và kiểm tra lại huyết áp trong 3 tháng

D. Bắt đầu dùng hydrochlorothiazide

E. Bắt đầu dùng losartan

Câu 9 ID 2732 Một người đàn ông 54 tuổi vô gia cư đến khoa cấp cứu 24 giờ sau khi khởi phát đau ngực sau xương ức và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim thành trước. Bệnh nhân không có tiền sử tăng huyết áp hay đái tháo đường và trước đây chưa từng bị đau ngực, khó thở, đánh trống ngực, ngất hay phù chân. Ông có tiền sử hút thuốc lá 40 bao-năm. Siêu âm tim cho thấy kích thước thất trái bình thường và giảm động thành trước thất trái, cũng như phân suất tống máu (EF) là 40%. Bệnh nhân từ chối điều trị nội khoa khi xuất viện và được lên lịch hẹn khám ngoại trú nhưng sau đó mất dấu theo dõi. Hai năm sau, bệnh nhân được một người bạn phát hiện đã tử vong. Khám nghiệm tử thi cho thấy tâm thất trái giãn to hình cầu và các thành mỏng đi với một vết sẹo ở thành trước. Thuốc nào sau đây có khả năng nhất giúp ngăn ngừa các phát hiện bệnh lý của bệnh nhân này?

A. Amlodipine

B. Apixaban

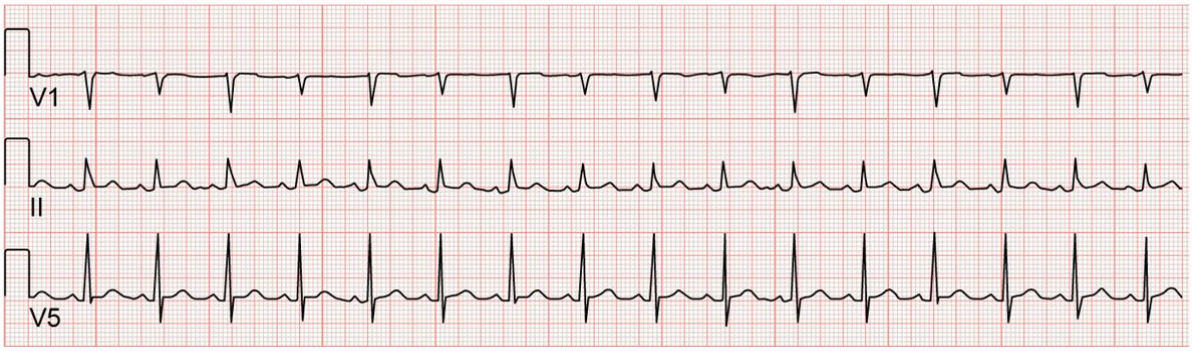
C. Aspirin

D. Enalapril

E. Isosorbide dinitrate

F. Prasugrel

Câu 10 ID 4390 Một người đàn ông 46 tuổi bị ngất khi bước ra khỏi giường. Bệnh nhân cảm thấy yếu trong vài ngày qua và có khó thở cùng cảm giác khó chịu ở ngực. Ông tin rằng các triệu chứng này là do một đợt nhiễm trùng đường hô hấp 2 tuần trước, nhưng lúc đó ông không đi khám bác sĩ. Tiền sử bệnh tật bao gồm tăng huyết áp đang được kiểm soát bằng lisinopril. Tiền sử gia đình có người mắc bệnh động mạch vành. Băng ghi nhịp điện tâm đồ (ECG) được hiển thị trong tài liệu đính kèm. Phương pháp điều trị nào sau đây là phù hợp nhất cho bệnh nhân này?



A. Adenosine

B. Amiodarone

C. Truyền tĩnh mạch Heparin

D. Magnesium sulfate

E. Metoprolol

F. Chọc hút dịch màng ngoài tim

G. Sốc điện chuyển nhịp đồng bộ

Câu 11 ID 15759 Một người phụ nữ 55 tuổi đến phòng khám do tình trạng khó thở dai dẳng. Trong năm qua, bà gặp khó khăn khi leo cầu thang lên phòng ngủ và làm việc nhà. Bệnh nhân cũng cảm thấy mệt mỏi vào cuối ngày. Bà không có đau ngực, ho, ngất, hay phù chi dưới. Tiền sử bệnh tật đáng chú ý với hội chứng ống cổ tay và suy giáp, hiện đang dùng levothyroxine. Bệnh nhân chưa bao giờ hút thuốc lá. Bà không có tiền sử gia đình mắc bệnh động mạch vành sớm. Huyết áp là 133/75 mmHg và nhịp mạch là 85 l/p, đều. Nghe phổi trong. Mỏm tim đập lệch sang trái, và sờ thấy rung miêu tâm thu. Nghe thấy tiếng thổi toàn tâm thu âm sắc cao, dạng thổi 4/6 ở mỏm tim. Dấu hiệu thực thể bổ sung nào sau đây có khả năng xuất hiện nhất ở bệnh nhân này?

A. Ngón tay dùi trống

B. Tiếng clắc mở van (Opening snap)

C. Tiếng T3

D. Tiếng T4

E. Mạch đập lưỡi gà (Uvular pulsation)

F. Tiếng T2 tách đôi rộng và cố định

Câu 12 ID 4679 Một người đàn ông 54 tuổi đến khoa cấp cứu sau khi thức giấc vào nửa đêm do cảm giác khó chịu ở vùng sau xương ức. Bệnh nhân cũng bị đau vùng cổ bên trái, vã mồ hôi và khó thở. Ông chưa bao giờ bị đau tương tự trước đây. Tiền sử bệnh tật đáng chú ý với đái tháo đường type 2 và tăng huyết áp. Ông có tiền sử hút thuốc lá 30 bao-năm. Dấu hiệu thực thể nào sau đây thường liên quan nhất đến bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân này?

A. Tiếng thổi tâm thu dạng tống máu

B. Tiếng T2 tách đôi cố định

C. Tiếng cọ màng tim

D. Mạch nghịch thường (Pulsus paradoxus)

E. Tiếng T4

Câu 13 ID 22663 Một nam thanh niên 17 tuổi được đưa đến phòng khám để khám sức khỏe định kỳ trước khi tham gia thể thao. Bệnh nhân không có triệu chứng. Cậu chơi bóng đá thi đấu cho trường trung học của mình. Huyết áp là 120/80 mmHg, nhịp mạch 62 l/p, và nhịp thở là 15 l/p. BMI là 27 kg/m². Bệnh nhân có thân hình vạm vỡ với khối lượng cơ xương tăng. Khám lâm sàng không có gì đặc biệt. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp xoang bình thường với sóng T âm ở các chuyển đạo V5 và V6. Siêu âm tim cho thấy phì đại thất trái kèm theo suy giảm đổ đầy tâm trương sớm và giãn nhẹ nhĩ trái. Chẩn đoán nào sau đây là có khả năng nhất ở bệnh nhân này?

A. Tim vận động viên (Athlete's heart)

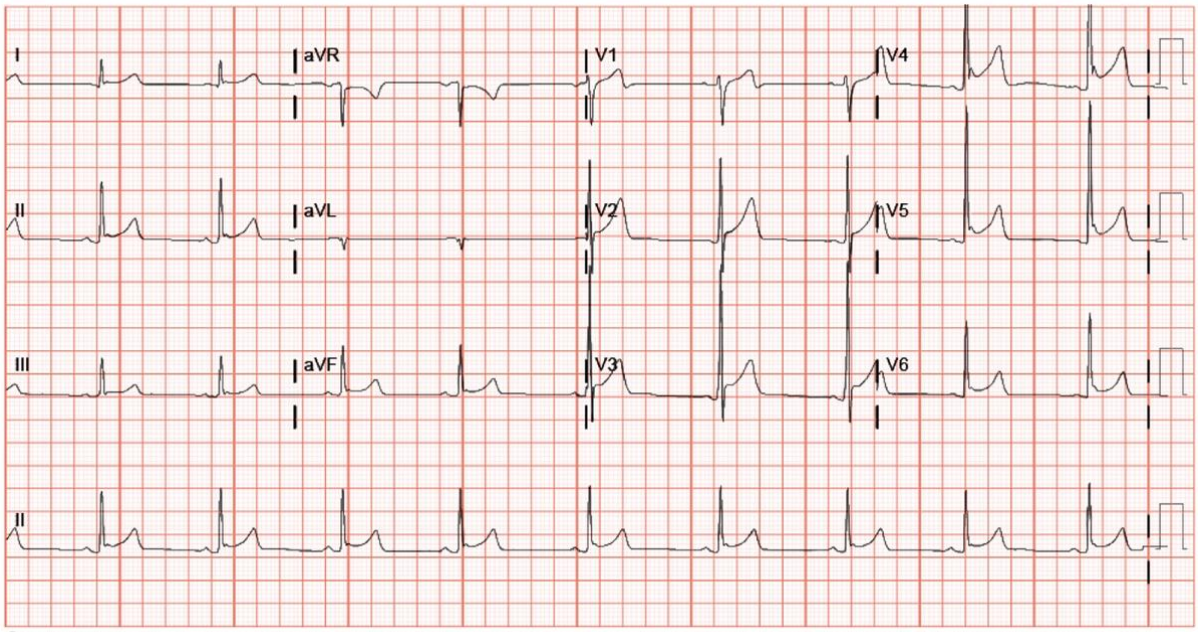
B. Hội chứng Brugada

C. Bệnh cơ tim phì đại

D. Tăng huyết áp chưa được chẩn đoán

Câu 14 ID 2729 Một người đàn ông 45 tuổi thừa cân nhẹ đang hồi phục sau nhồi máu cơ tim thành trước thì xuất hiện cơn đau nhói, khởi phát đột ngột ở ngực trái. Cơn đau tăng lên khi ho và giảm đi khi ngồi dậy cúi người về phía trước. Bệnh nhân đã đến khoa cấp cứu 3 ngày trước với cơn đau tức sau xương ức và vã mồ hôi kéo dài 10 giờ. Ông đã được chụp mạch vành và đặt stent động mạch liên thất trước (LAD). Bệnh nhân không bị khó thở, đánh trống ngực, hay phù chi kể từ khi nhập viện. Tiền sử bệnh tật đáng chú ý có đái tháo đường

type 2. Huyết áp là 120/78 mmHg, và nhịp mạch là 60 l/p. Huyết áp không thay đổi khi hít vào sâu. Bệnh nhân có vẻ bồn chồn nhẹ, đặc biệt là ở tư thế nằm ngửa. Nhịp thở của ông nhanh và nông. Nghe phổi trong. Điện tâm đồ (ECG) được hiển thị trong tài liệu đính kèm. Chẩn đoán nào sau đây là có khả năng nhất cho bệnh nhân này?



©UWorld

A. Viêm màng ngoài tim cấp

B. Huyết khối trong stent cấp tính

C. Lóc tách động mạch chủ

D. Viêm phổi bệnh viện

E. Vỡ vách liên thất

F. Đứt cơ nhú (Papillary muscle rupture)

G. Thuyên tắc phổi

H. Phình vách tâm thất

I. Vỡ thành tự do tâm thất

Câu 15 ID 20965 Một người phụ nữ 61 tuổi đến phòng khám do tình trạng tăng huyết áp. Huyết áp là 152/92 mmHg cách đây một tháng; bà đã theo dõi huyết áp tại nhà kể từ đó, với mức trung bình là 148/88 mmHg. Tình trạng bệnh lý duy nhất khác của bệnh nhân là loãng xương, được chẩn đoán cách đây 6 tháng và đang điều trị bằng vitamin D, canxi, và alendronate. Hôm nay tại phòng khám, huyết áp là 156/90 mmHg ở tay trái và 152/92 mmHg ở tay phải, nhịp mạch 70 l/p. Khám lâm sàng bình thường. Tổng phân tích tế bào máu, creatinin huyết thanh, điện giải đồ huyết thanh, TSH, và tổng phân tích nước tiểu đều

bình thường. ECG bình thường. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là tốt nhất trong việc kiểm soát huyết áp của bệnh nhân này?

A. Chỉ khuyên sửa đổi lối sống

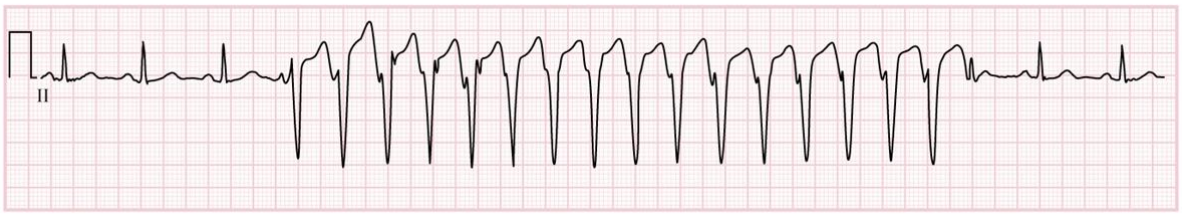
B. Đổi alendronate sang denosumab

C. Ngừng bổ sung canxi

D. Bắt đầu dùng atenolol

E. Bắt đầu dùng chlorthalidone

Câu 16 ID 2659 Một người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì sốt và khó thở. Ông bị viêm gan C mạn tính, HIV, và bệnh cơ tim do rượu. Nhiệt độ là 38.6 C (101.5 F). Có nấm miệng (thrush) ở hầu họng. X-quang ngực cho thấy đông đặc thùy dưới phổi phải. Ông được bắt đầu điều trị bằng fluconazole và moxifloxacin. Tình trạng viêm phổi và nấm miệng cải thiện trong 2 ngày tiếp theo. Tuy nhiên, vào ngày thứ ba, bệnh nhân xuất hiện các cơn đánh trống ngực tái phát, mỗi cơn kéo dài 5-10 giây. Một băng ghi nhịp được ghi lại trong một cơn đánh trống ngực được hiển thị trong tài liệu đính kèm. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là phù hợp nhất cho bệnh nhân này?



A. Adenosine

B. Amiodarone

C. Calcium gluconate

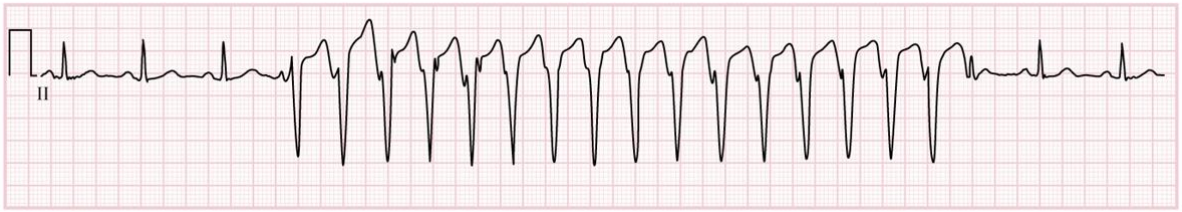
D. Magnesium sulfate

E. Sodium bicarbonate

F. Sotalol

Câu 17 ID 2164 Một người phụ nữ 42 tuổi đến khoa cấp cứu do khó thở tăng dần và phù chi dưới. Bà không bị đau ngực, đánh trống ngực, hay ngất. Bệnh nhân có tiền sử suy tim phân suất tống máu giảm do bệnh cơ tim chu sản (peripartum cardiomyopathy). Phân suất tống máu thất trái là 30% vào thời điểm 2 tháng trước. Khám lâm sàng ghi nhận áp lực tĩnh mạch cổ nổi, ran nổ ở đáy phổi hai bên, và phù mềm ấn lõm chi dưới hai bên. Bệnh nhân được cho nhập viện, và bắt đầu tiêm tĩnh mạch furosemide theo lịch trình ngoài các thuốc đang dùng tại nhà. Vào ngày thứ 3 nằm viện, nhịp tim hiển thị trong tài liệu đính kèm được ghi nhận trên màn hình theo dõi từ xa (telemetry). Nhịp này kéo dài trong vài giây trước khi tự trở về nhịp xoang. Bệnh nhân không có triệu chứng trong suốt sự kiện này. Các dấu hiệu

sinh tồn đều trong giới hạn bình thường. Khám lâm sàng cho thấy tình trạng ran nổ ở phổi và phù chân đã cải thiện. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là tốt nhất cho tình trạng rối loạn nhịp tim của bệnh nhân này?



A. Sử dụng thuốc chống loạn nhịp

B. Bắt đầu dùng thuốc chống đông toàn thân

C. Đo điện giải đồ huyết thanh

D. Theo dõi và không can thiệp gì thêm

E. Thực hiện nghiệm pháp gắng sức tim

Câu 18 ID 3768 Một người đàn ông 67 tuổi đến khoa cấp cứu do xây xẩm mặt mày và mệt mỏi toàn thân trong 2 ngày qua. Bệnh nhân bị đau thắt ngực ổn định mạn tính khi gắng sức. Trong 2 ngày qua, ông cũng thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu ở ngực lúc nghỉ ngơi. Tiền sử bệnh tật bao gồm tăng huyết áp và hen phế quản. Bệnh nhân không bị khó thở, ho, hay phù ngoại vi. Các loại thuốc duy nhất ông đang dùng là aspirin và isosorbide dinitrate. Huyết áp là 105/66 mmHg. Điện tâm đồ (ECG) đo tại khoa cấp cứu được hiển thị trong tài liệu đính kèm. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là tốt nhất cho bệnh nhân này?



©UWorld

A. Adenosine

B. Tạo nhịp tim (Cardiac pacing)

C. Digoxin

D. Liệu pháp tiêu sợi huyết

E. Metoprolol

Câu 19 ID 2695 Một người phụ nữ 48 tuổi đến phòng khám do thỉnh thoảng bị đánh trống ngực. Bà mô tả nhịp tim nhanh và không đều. Bà đã có 3 cơn như vậy trong 2 tháng qua, mỗi cơn kéo dài khoảng 2 giờ. Bệnh nhân không có đau ngực, mệt mỏi, khó thở, ho, hay phù mắt cá chân kèm theo. Bà có uống rượu trong các dịp giao tiếp xã hội và không hút thuốc. Bà không có vấn đề y khoa nào khác và không dùng thuốc gì. Bà làm kế toán và

chưa từng đi du lịch ra ngoài tiểu bang California nơi bà sinh sống. Nhiệt độ là 37.1 C (98.8 F), huyết áp 130/70 mmHg, nhịp mạch 80 l/p, và nhịp thở là 14 l/p. Mỏm tim đập lệch sang trái, và nghe thấy tiếng T3 ở mỏm tim ở tư thế nằm nghiêng trái. Cũng có một tiếng thổi tâm thu nghe lớn nhất ở mỏm tim và lan ra nách. Nguyên nhân nào sau đây có khả năng nhất gây ra tình trạng của bệnh nhân này?

A. Nhiễm khuẩn van hai lá

B. Vôi hóa vòng van hai lá

C. Thiếu máu cục bộ cơ tim

D. Thoái hóa nhầy van hai lá (Myxomatous degeneration of the mitral valve)

E. Bệnh van hai lá do thấp (Rheumatic mitral valve disease)

Câu 20 ID 15974 Một người đàn ông 32 tuổi đến phòng khám để tái khám tình trạng tăng huyết áp. Một tuần trước, anh ta đã đến khoa cấp cứu vì chảy máu cam và được phát hiện bị tăng huyết áp. Bệnh nhân không có tiền sử bệnh tật nào đáng kể. Cả bố và mẹ đều còn sống; bố anh được chẩn đoán mắc bệnh động mạch vành ở tuổi 55, và mẹ anh bị tăng huyết áp và đái tháo đường. Huyết áp là 150/95 mmHg, và các lần đo huyết áp lặp lại đều cho kết quả tương tự. Nhịp mạch là 96 l/p và đều. BMI là 27 kg/m². Khám lâm sàng không thấy có tiếng thổi ở tim. Không có tuyến giáp to hay nổi hạch hạch ngoại vi. Bệnh nhân có biểu hiện run tay biên độ nhỏ (fine hand tremor). Không ghi nhận phát ban trên da. Kết quả xét nghiệm cho thấy TSH huyết thanh là 1.2 µU/mL, điện giải đồ huyết thanh bình thường, và creatinin là 0.7 mg/dL. Bước tiếp theo nào sau đây là tốt nhất trong việc đánh giá bệnh nhân này?

A. Siêu âm Doppler động mạch thận

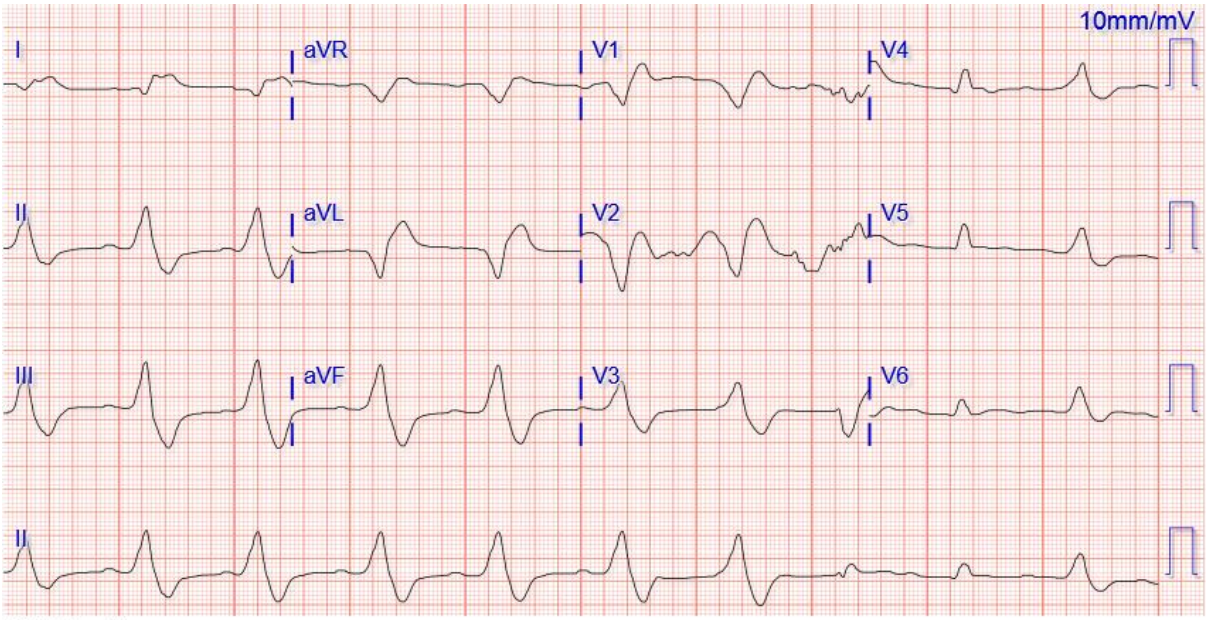
B. Đa ký giấc ngủ tại phòng xét nghiệm (In-laboratory polysomnography)

C. Metanephrine phân đoạn trong huyết tương (Plasma fractionated metanephrines)

D. Nồng độ aldosterone huyết thanh

E. Sàng lọc độc chất trong nước tiểu

Câu 21 ID 19929 Một người phụ nữ 76 tuổi được xe cấp cứu đưa đến khoa cấp cứu do lú lẫn. Chồng bà cho biết bà bị ung thư thực quản di căn và không thể ăn uống trong vài ngày qua. Hôm qua, bà trở nên lờ đờ hơn, và hôm nay bà rất khó đánh thức. Nhiệt độ là 37.1 C (98.8 F), huyết áp 80/30 mmHg, nhịp mạch 60 l/p, và nhịp thở là 30 l/p. Độ bão hòa oxy (SpO2) là 95% với khí trời. Bệnh nhân có vẻ lờ đờ nhưng có mở mắt khi gọi hỏi. Niêm mạc khô. Đã đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi, chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng, và bắt đầu truyền dịch tĩnh mạch. Một băng ghi nhịp điện tâm đồ (ECG) được hiển thị trong tài liệu đính kèm. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là tốt nhất?



A. Tiêm atropine

B. Tiêm calcium gluconate

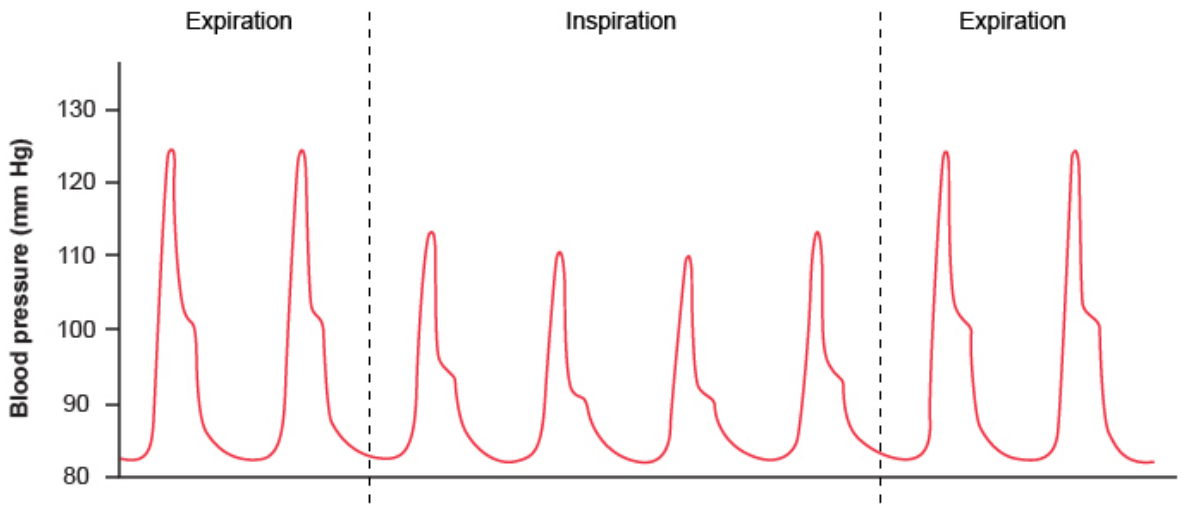
C. Tiêm magnesium sulfate

D. Tiêm norepinephrine

E. Đặt máy tạo nhịp qua da

Câu 22 ID 4771

Một người phụ nữ 34 tuổi đến khoa cấp cứu với triệu chứng khó thở và chóng mặt. Bệnh nhân được đặt catheter động mạch và biểu đồ huyết áp của cô được hiển thị dưới đây.



Chẩn đoán nào sau đây phù hợp nhất với các dấu hiệu này?

A. Hở van động mạch chủ

B. Viêm phổi thùy

C. Hẹp van hai lá

D. Cơn hoảng sợ (Panic attack)

E. Hen phế quản nặng

Câu 23 ID 4725 Một người đàn ông 55 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu do đột ngột xuất hiện đánh trống ngực và tức ngực. Các vấn đề y khoa khác của ông bao gồm tăng huyết áp, gout, và đái tháo đường type 2. Theo dõi tim mạch cho thấy rung nhĩ với tần số 120-140 l/p. Huyết áp ban đầu của ông là 112/70 mmHg, và độ bão hòa oxy là 92% với khí trời. Khi điều dưỡng cố gắng thiết lập đường truyền tĩnh mạch, bệnh nhân mất ý thức. Không bắt được mạch cảnh hoặc mạch đùi, và bệnh nhân thở ngáp cá. Màn hình theo dõi tim vẫn cho thấy rung nhĩ với cùng tần số. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là tốt nhất cho bệnh nhân này?

A. Phân tích khí máu động mạch

B. Ép tim ngoài lồng ngực

C. Khử rung tim (Defibrillation)

D. Tiêm tĩnh mạch lidocaine

E. Sốc điện chuyển nhịp đồng bộ

Câu 24 ID 2735 Một người đàn ông 47 tuổi đến khoa cấp cứu do khởi phát đau lưng cấp tính cách đây 6 giờ. Cơn đau bắt đầu ở giữa hai xương bả vai và hiện tại khu trú ở mạn sườn trái. Bệnh nhân làm nghề thầu sửa chữa nhà cửa và đang lắp ráp sàn sân sau thì cơn đau bắt đầu. Ông mô tả cơn đau có cảm giác xé rách, với cường độ tối đa ngay khi khởi phát, và là cơn đau tồi tệ nhất mà ông từng trải qua. Bệnh nhân chưa đi tiểu kể từ khi cơn đau bắt đầu. Ông không có bệnh lý mạn tính nào đã biết nhưng đã vài năm không đi khám bác sĩ. Ông uống 2 hoặc 3 cốc bia mỗi ngày. Bố ông đột tử ở tuổi 50 do đau tim và mẹ ông bị sỏi thận. Bệnh nhân đang vật vã do đau. Huyết áp là 158/90 mmHg và nhịp mạch là 104 l/p, đều ở cả hai tay. Khám lâm sàng, âm phế bào và tiếng tim bình thường. Bụng không chướng, âm ruột bình thường. Khám thần kinh không thấy bất thường. Kết quả xét nghiệm như sau: Tổng phân tích tế bào máu Hemoglobin 13 g/dL Tiểu cầu 260,000/mm³ Bạch cầu 10,000/mm³ Sinh hóa máu BUN 18 mg/dL Creatinin 2 mg/dL Tổng phân tích nước tiểu Protein âm tính Bạch cầu 1-2/vi trường vật kính độ phóng đại lớn (hpf) Hồng cầu 20-30/vi trường vật kính độ phóng đại lớn (hpf) Trụ niệu âm tính Siêu âm thận cho thấy thận kích thước bình thường, không có ứ nước. Yếu tố nguy cơ lớn nhất cho tình trạng cấp tính của bệnh nhân này là gì?

A. Sử dụng rượu

B. Tiền sử gia đình bị sỏi thận

C. Mảng xơ vữa động mạch

D. Tăng huyết áp

E. Nghề nghiệp

Câu 25 ID 8928 Một người đàn ông 64 tuổi đến phòng khám do đau quặn ở đùi phải sau khi đi bộ 2 khu phố. Cơn đau biến mất khi ông dừng lại và nghỉ ngơi trong vài phút. Bệnh nhân từng hút thuốc lá với tiền sử 35 bao-năm. Ông không có tiền sử đái tháo đường, bệnh động mạch vành, hay đột quỵ. Các dấu hiệu sinh tồn bình thường. Khám lâm sàng, mạch đùi bình thường, nhưng mạch khoeo và mạch mu chân giảm ở chân phải. Chỉ số huyết áp cổ chân-cánh tay (ABI) là 0.98 ở bên trái và 0.72 ở bên phải. Ông được kê đơn aspirin liều thấp và statin cường độ cao. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là tốt nhất cho bệnh nhân này?

A. Chụp động mạch sau đó phẫu thuật bắc cầu nối

B. Chụp cắt lớp vi tính (CT) mạch máu sau đó đặt stent

C. Pentoxifylline

D. Chương trình tập thể dục có giám sát

E. Warfarin

Câu 26 ID 4450 Một người phụ nữ 25 tuổi được đánh giá vì thỉnh thoảng có các đợt đánh trống ngực. Cô ấy mô tả các đợt này là nhịp tim nhanh, đều đặn, khởi phát đột ngột khiến cô cảm thấy như "tim đang đua trong ngực". Các đợt này thường không có nguyên nhân rõ ràng và không liên quan đến gắng sức. Trong một đợt, huyết áp của cô được ghi nhận là 100/60 mmHg và nhịp tim là 185 l/p, đều. Cô không có tiền sử bệnh tật nào đáng kể và không dùng thuốc gì. Cô không có tiền sử gia đình mắc bệnh tim. Khám lâm sàng không có gì đặc biệt, bao gồm không có tiếng thổi ở tim hay tiếng tim bệnh lý. Cô cũng cho biết mình tự điều trị bằng cách ngâm mặt vào nước lạnh trong các đợt đánh trống ngực. Nhìn chung, cô nói, ngâm nước lạnh làm giảm các triệu chứng của cô một cách đột ngột trong vòng vài phút. Thủ thuật này chấm dứt cơn đánh trống ngực bằng cách trực tiếp làm thay đổi yếu tố nào sau đây?

A. Tính dẫn truyền của nút nhĩ thất

B. Dẫn truyền sợi Purkinje

C. Tính tự động của nút xoang nhĩ

D. Trương lực mạch máu

E. Lượng máu tĩnh mạch trở về tim

F. Sức co bóp cơ tim tâm thất

Câu 27 ID 16704 Một người đàn ông 78 tuổi đến phòng khám để khám ngoại trú định kỳ. Bệnh nhân cho biết không có triệu chứng gì. Tiền sử bệnh tật đáng chú ý với tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính giai đoạn đầu, và hẹp van động mạch chủ vôi hóa. Tám tháng trước, ông đã trải qua thủ thuật thay van động mạch chủ qua đường ống thông (TAVI) qua đường

động mạch đùi mà không có biến chứng đáng kể nào. Siêu âm tim gần đây cho thấy chức năng thất trái bình thường và không có bằng chứng rối loạn chức năng van thay qua đường ống thông. Bệnh nhân dự định sẽ lấy cao răng định kỳ, lần lấy cao răng gần nhất là một năm trước. Ông hỏi về sự cần thiết phải dùng kháng sinh trước thủ thuật. Câu trả lời nào sau đây là tốt nhất?

A. "Không, vì đã hơn 6 tháng sau thủ thuật."

B. "Không, vì bác đang dự định làm một thủ thuật nguy cơ thấp."

C. "Không, vì bác có van không khâu (sutureless valve)."

D. "Có, vì bác có van nhân tạo."

E. "Có, vì bác có vôi hóa xung quanh van mới."

Câu 28 ID 12340 Một người phụ nữ 64 tuổi nhập viện do nhồi máu cơ tim cấp thành trước. Bà nhập viện với bệnh sử 24 giờ đau rát vùng giữa ngực dai dẳng và được phát hiện tắc hoàn toàn đoạn giữa động mạch liên thất trước. Can thiệp động mạch vành qua da đã được thực hiện thành công với việc đặt stent kim loại trần (bare metal stent). Tiền sử bệnh tật của bệnh nhân đáng chú ý với đái tháo đường type 2 không kiểm soát, tăng huyết áp, tăng mỡ máu, và đang hút thuốc lá. Bà có tiền sử gia đình mắc đái tháo đường, đột quỵ, và bệnh động mạch vành rõ rệt. Vào ngày thứ tư nằm viện, bệnh nhân xuất hiện khó thở cấp tính và lú lẫn. Huyết áp là 72/40 mmHg và nhịp tim là 120 l/p, nhịp đều. Khám lâm sàng cho thấy các chi lạnh, ẩm ướt và vã mồ hôi. Có tĩnh mạch cổ nổi khi bệnh nhân ở tư thế nửa nằm nửa ngồi. Nghe phổi có ran nổ ở đáy phổi hai bên. Có tiếng thổi toàn tâm thu lớn, thô ráp ở bờ trái xương ức kèm rung miêu. Bụng mềm, hơi ấn đau ở hạ sườn phải. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp nhanh xoang với sóng T âm sâu ở các chuyển đạo V1 đến V5. Nguyên nhân nào sau đây có khả năng nhất gây ra tình trạng xấu đi của bệnh nhân này?

A. Huyết khối trong stent cấp tính

B. Lóc tách động mạch chủ

C. Thủng van động mạch chủ

D. Vỡ thành tự do cơ tim

E. Đứt cơ nhú

F. Ép tim cấp (Pericardial tamponade)

G. Vỡ vách liên thất

Câu 29 ID 3065 Một người đàn ông 34 tuổi đến phòng khám do bệnh sử 5 tháng khó thở khi gắng sức không kèm theo đau ngực, đánh trống ngực, chóng mặt, hay ngất. Bệnh nhân gần đây nhập cư từ Brazil. Tiền sử bệnh tật đáng chú ý với một đợt phình đại tràng (megacolon), đã được điều trị 2 năm trước. Khám lâm sàng, có phù chi 1+ và tĩnh mạch cổ nổi nhẹ. Khám tim mạch đáng chú ý với sự hiện diện của tiếng T3. Không nghe thấy tiếng thổi. X-quang

ngực cho thấy bóng tim to rõ rệt. Nguyên nhân nào sau đây có khả năng nhất gây ra các triệu chứng của bệnh nhân?

A. Viêm cơ tim do bạch hầu

B. Bệnh động mạch vành

C. Bệnh do động vật nguyên sinh (Protozoal disease)

D. Viêm cơ tim tế bào khổng lồ

E. Viêm cơ tim do Rickettsia

Câu 30 ID 3056 Một người đàn ông 48 tuổi đến khoa cấp cứu do đau ngực dữ dội bắt đầu cách đây 2 giờ. Ông khó xác định vị trí đau, nói rằng "đau khắp ngực". Ông không bị khó thở, xây xẩm mặt mày, ngất, hay đánh trống ngực. Bệnh nhân không có bệnh lý y khoa nào đã biết. Ông không sử dụng thuốc lá, rượu, hay chất kích thích. Bố ông đột tử ở tuổi 52 do nghi ngờ đau tim. Nhiệt độ là 36.7 C (98.1 F), huyết áp 178/102 mmHg, nhịp mạch 105 l/p và đều, nhịp thở là 16 l/p. Khám lâm sàng, nghe phổi trong và tiếng tim bình thường. Điện tâm đồ (ECG) cho thấy nhịp nhanh xoang, tiêu chuẩn điện thế phì đại thất trái, và sóng T âm ở các chuyển đạo V5 và V6. Một hình ảnh CT ngực được hiển thị trong tài liệu đính kèm. Ngoài việc kiểm soát đau, liệu pháp điều trị bằng thuốc ngay lập tức nào sau đây là phù hợp nhất cho bệnh nhân này?



A. Thuốc ức chế men chuyển (ACE inhibitor)

B. Hydralazine

C. Labetalol

D. Nitroprusside

E. Chất hoạt hóa plasminogen mô (Tissue plasminogen activator)

F. Heparin không phân đoạn

Câu 31 ID 4922 Một người đàn ông 42 tuổi đến phòng khám do đánh trống ngực tái phát. Sau đánh giá ban đầu, bệnh nhân được chẩn đoán mắc rung nhĩ kịch phát. Siêu âm tim cho thấy chức năng thất trái bình thường và không có bệnh lý van tim. Bệnh nhân được bắt đầu điều trị bằng thuốc. Hai tuần sau, bệnh nhân thực hiện nghiệm pháp gắng sức trên thảm lăn. Trong quá trình làm nghiệm pháp, nhịp tim của bệnh nhân tăng từ 75 l/p lên 165 l/p và thời gian phức bộ QRS tăng từ 0.09 giây lên 0.13 giây. Thuốc nào sau đây có khả năng nhất gây ra các phát hiện quan sát được?

A. Amlodipine

B. Digoxin

C. Flecainide

D. Metoprolol

E. Verapamil

Câu 32 ID 4680 Một người đàn ông 32 tuổi đến phòng khám để khám sức khỏe định kỳ trước khi đi làm. Anh cảm thấy khỏe mạnh. Mười năm trước, bố anh đột tử ở tuổi 54. Huyết áp là 175/103 mmHg ở tay phải và 180/105 mmHg ở tay trái, nhịp mạch là 82 l/p. BMI là 22.1 kg/m². Nghe phổi trong hai bên và tiếng tim bình thường. Khám sờ thấy các khối ở vùng bụng trên hai bên, không đau. Nồng độ hemoglobin là 15.2 g/dL và nồng độ creatinin là 0.8 mg/dL. Bước tiếp theo nào sau đây là phù hợp nhất trong việc đánh giá tình trạng của bệnh nhân này?

A. Cortisol nước tiểu 24 giờ

B. Siêu âm ổ bụng

C. Xạ hình thận tăng cường bằng Captopril

D. Tỷ số aldosterone/renin huyết tương

E. Metanephrine nước tiểu

Câu 33 ID 16031 Một người đàn ông 62 tuổi được đưa đến khoa cấp cứu sau khi mất ý thức tại nhà thờ 30 phút trước đó. Bệnh nhân đang tham dự buổi lễ cùng vợ thì đột nhiên mất ý thức. Bệnh nhân được ghi nhận có các cử động giật ngắn ở cánh tay. Bệnh nhân được đỡ nằm xuống sàn và hồi tỉnh, trở lại trạng thái tâm thần ban đầu sau khoảng 2 phút. Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân tỉnh táo, nhận biết tốt, và có đau nhẹ ở lưỡi. Bệnh nhân đã có

một đợt tương tự cách đây 3 tuần; khi đang ngồi trên bồn cầu, ông trở nên mất phương hướng và sau đó thấy mình đang nằm trên sàn phòng tắm. Ông không có biểu hiện xây xẩm mặt mày hay đau ngực trước các sự kiện này. Tiền sử bệnh tật bao gồm tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, và đột quỵ không để lại di chứng thần kinh. Các dấu hiệu sinh tồn đều trong giới hạn bình thường, và không có thay đổi tư thế. Có một vết rách nhỏ, không chảy máu ở bờ ngoài của lưỡi. Nghe phổi trong, và tiếng tim bình thường. Khám thần kinh cho thấy các dây thần kinh sọ bình thường; không có yếu liệt khu trú hay mất cảm giác. Dấu hiệu nào sau đây ở bệnh nhân này gợi ý nhiều nhất đến cơn động kinh so với ngất?

A. Cử động bất thường ở các chi

B. Cắn phải lưỡi kèm theo

C. Tính chất từng đợt của các triệu chứng

D. Tư thế của bệnh nhân lúc khởi phát

E. Thời gian chuyển tiếp để trở về trạng thái ban đầu

Câu 34 ID 4459 Một người đàn ông 45 tuổi đến phòng khám do khó thở khi gắng sức và mệt mỏi. Bệnh nhân dành phần lớn thời gian ở trong nhà vì các triệu chứng của mình. Bệnh nhân bị bệnh thận giai đoạn cuối do viêm cầu thận, và 6 tháng trước bệnh nhân bắt đầu chạy thận nhân tạo qua đường rò động tĩnh mạch (AVF). Bệnh nhân đã duy trì mức cân nặng gần với "trọng lượng khô" của mình, và hemoglobin của bệnh nhân đã được duy trì trong giới hạn mong muốn bằng cách bổ sung sắt và erythropoietin. Bệnh nhân không sốt. Huyết áp là 160/60 mmHg và nhịp mạch là 100 l/p, đều. Độ bão hòa oxy là 96% với khí trời. Đường rò động tĩnh mạch ở cánh tay phải phồng lên với mạch đập rất mạnh. Mạch cảnh nảy mạnh. Điểm đập tối đa của mỏm tim lệch sang trái, và nghe thấy một tiếng thổi tâm thu nhẹ ở mỏm tim, không thay đổi khi làm nghiệm pháp Valsalva. Nghe thấy ran nổ rải rác ở đáy phổi. Các chi ấm, và có phù ngoại vi nhẹ. Nguyên nhân nào sau đây có khả năng nhất gây ra các triệu chứng của bệnh nhân này?

A. Giảm cung lượng tim

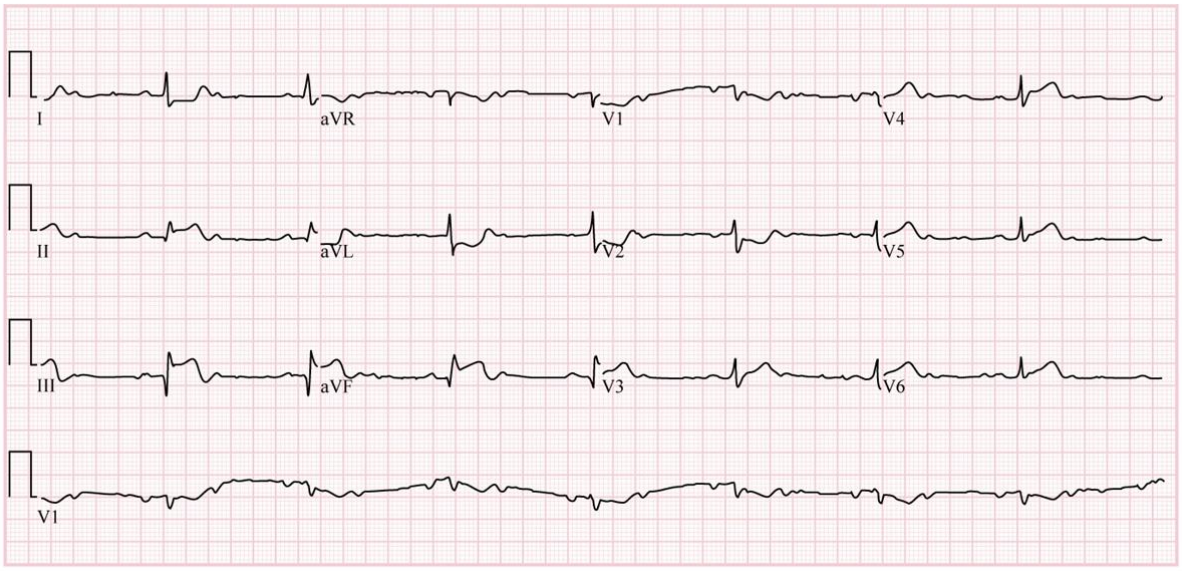
B. Sa lá van hai lá (Flail mitral leaflet)

C. Bệnh cơ tim phì đại

D. Tăng áp động mạch phổi vô căn

E. Tăng tiền gánh tim

Câu 35 ID 4108 Một người đàn ông 60 tuổi đến khoa cấp cứu do khởi phát đột ngột buồn nôn, nôn mửa, vã mồ hôi, và đau ngực. Tiền sử bệnh tật bao gồm tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, và hẹp van động mạch chủ nhẹ. Bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá 45 bao-năm. Nhiệt độ là 37.2 C (99 F), huyết áp 85/55 mmHg, nhịp mạch 58 l/p, và nhịp thở là 18 l/p. Đo bão hòa oxy qua mạch đập cho thấy 98% với khí trời. Khám lâm sàng cho thấy áp lực tĩnh mạch cổ nổi, tiếng T1 và T2 bình thường. Nghe phổi trong. Điện tâm đồ (ECG) được hiển thị trong tài liệu đính kèm. Cơ chế nào sau đây có khả năng nhất gây ra tình trạng của bệnh nhân này?



A. Viêm màng ngoài tim

B. Tắc động mạch liên thất trước (LAD)

C. Tắc thân chung động mạch vành trái (LMCA)

D. Tắc động mạch vành phải (RCA)

Câu 36 ID 4741 Một người đàn ông 63 tuổi đến khoa cấp cứu với triệu chứng đau vùng sau xương ức và vã mồ hôi. Cơn đau bắt đầu cách đây một giờ và không giảm khi dùng thuốc kháng axit. Các vấn đề y khoa của ông bao gồm hen phế quản, hiện đang dùng fluticasone dạng hít, và bệnh loét dạ dày tá tràng, hiện đang dùng omeprazole. Huyết áp là 160/100 mmHg và nhịp mạch là 90 l/p. Nghe thấy tiếng thổi ở động mạch cảnh phải, và có một tiếng thổi tâm thu nhẹ ở mỏm tim. Bệnh nhân được cho ngậm dưới lưỡi nitroglycerin và uống aspirin, và trong vòng vài phút bệnh nhân cho biết cơn đau đã hết. Yếu tố nào sau đây có khả năng nhất giải thích cho sự cải thiện các triệu chứng của bệnh nhân?

A. Thay đổi nhịp tim

B. Giảm phân suất tống máu thất trái

C. Giảm thể tích cuối tâm trương thất trái

D. Tăng tiền gánh tim

E. Tăng độ giãn nở thất trái

F. Tăng hậu gánh hệ thống

Câu 37 ID 2742 Một người đàn ông 43 tuổi đến phòng khám do thường xuyên có cảm giác nóng rát vùng thượng vị không thuyên giảm khi dùng thuốc kháng axit trong 4 tháng qua. Cảm giác này thường xuất hiện khi mang vác vật nặng tại nơi làm việc và mất 10-15 phút mới hết. Bệnh nhân không có đau cánh tay hay cổ, ho, khó thở, hay khó nuốt kèm theo.

Tiền sử bệnh tật của ông đáng chú ý với bệnh lupus ban đỏ hệ thống được chẩn đoán cách đây 5 năm, hiện đang dùng prednisone liều thấp và hydroxychloroquine. Ông chưa bao giờ hút thuốc lá. Một năm trước, vợ bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh loét dạ dày tá tràng cần điều trị bằng kháng sinh. Khám lâm sàng, huyết áp là 140/90 mmHg và nhịp mạch là 80 l/p, đều. Âm phế bào đều hai bên. Không nghe thấy tiếng rít hay ran nổ. Tiếng tim thứ nhất và thứ hai hiện diện. Không ghi nhận tiếng thổi hay tiếng cọ tim. Bụng mềm và không đau khi sờ sâu. Không có phát ban trên da hay phù ngoại vi. Điện tâm đồ (ECG) bình thường. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là tốt nhất cho bệnh nhân này?

A. Chụp CT ổ bụng có/không có cản quang

B. Siêu âm ổ bụng

C. Chụp CT ngực không cản quang

D. Chụp mạch vành

E. Siêu âm tim

F. Đo áp lực nhu động thực quản (Esophageal motility studies)

G. Điện tâm đồ gắng sức (Exercise ECG)

H. Xét nghiệm kháng nguyên Helicobacter pylori trong phân

I. Nội soi đường tiêu hóa trên

Câu 38 ID 4270 Một người đàn ông 62 tuổi đến khoa cấp cứu do bệnh sử 2 tuần khó thở và mệt mỏi. Bệnh nhân dễ bị hụt hơi khi đi bộ quãng đường ngắn và bị ho khan về đêm, mà ông cho là do dị ứng theo mùa. Ông không bị đau hay tức ngực, đánh trống ngực, xây xẩm mặt mày, hay ngất. Bệnh nhân đã không đi khám bác sĩ trong hơn 10 năm và chưa được chẩn đoán mắc bệnh lý y khoa nào. Ông có tiền sử hút thuốc lá 25 bao-năm và thỉnh thoảng uống rượu giao tiếp. Bệnh nhân không có tiền sử gia đình mắc bệnh tim. Ông làm việc trong ngành xây dựng hầu hết cuộc đời. Huyết áp là 138/80 mmHg và nhịp mạch là 94 l/p, đều. BMI là 24 kg/m². Yếu tố nào sau đây sẽ hữu ích nhất để loại trừ suy tim là nguyên nhân gây ra các triệu chứng của bệnh nhân này?

A. Không nghe thấy tiếng T3

B. Không có ran nổ khi nghe phổi

C. Nồng độ brain natriuretic peptide bình thường (<100 pg/mL)

D. Tỷ lệ tim-lồng ngực bình thường trên X-quang ngực

E. Áp lực tĩnh mạch cổ bình thường

Câu 39 ID 4455 Một người đàn ông 67 tuổi đến khoa cấp cứu sau khi mất ý thức trong lúc xúc tuyết gần nhà. Bệnh nhân cho biết ông đã có một đợt tương tự cách đây một tháng khi đang xách các túi nặng từ cửa hàng tạp hóa. Bệnh nhân đã giảm mức độ hoạt động thể

chất trong năm qua do khó thở và mệt mỏi tăng dần khi gắng sức. Ông không bị đau ngực, đánh trống ngực, ho, hay phù chi dưới. Các vấn đề y khoa khác của ông bao gồm đái tháo đường type 2 và tăng cholesterol máu. Ông chưa bao giờ hút thuốc lá. Dấu hiệu thực thể nào sau đây có khả năng nhất ở bệnh nhân này?

A. Chênh lệch huyết áp giữa chi trên và chi dưới

B. Tiếng thổi tâm trương muộn ở mỏm tim

C. Dấu hiệu mạch mao mạch nổi bật ở đầu ngón tay

D. Huyết áp tâm thu giảm >10 mmHg khi hít vào

E. Huyết áp tâm thu giảm >20 mmHg khi đứng lên

F. Mạch cảnh yếu và nảy chậm

Câu 40 ID 3697 Một người đàn ông 64 tuổi có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2 kiểm soát bằng chế độ ăn uống, đến phòng khám do khó chịu toàn thân và đánh trống ngực trong 2 tuần qua. Siêu âm tim năm ngoái cho thấy giãn nhẹ nhĩ trái và phì đại thất trái. Các loại thuốc bệnh nhân đang dùng bao gồm lisinopril và hydrochlorothiazide. Huyết áp là 170/90 mmHg. Băng ghi nhịp điện tâm đồ (ECG) được hiển thị trong tài liệu đính kèm. Bước xử trí tiếp theo nào sau đây là phù hợp nhất cho bệnh nhân này?



©UWorld

A. Adenosine

B. Sốc điện chuyển nhịp cấp cứu

C. Xoa xoang cảnh

D. Diltiazem

E. Lidocaine